Beispiel 11: ÖR 06, Anfängerhausarbeit: „Wie du mir, so ich dir“, veröffentlicht 2024

Volltexte zum Nachschlagen. Gefragt wird nur im Formular, diese Datei enthält die vollständigen Texte, aus denen die Belege stammen. Der Wortlaut ist unverändert aus den Dateien der Studie übernommen, umgesetzt ist nur die Formatierung (Überschriften, Hervorhebungen, Listen). Die Zeilennummern der Antwort sind die „Z.“ im Formular.

Inhalt. 1 Bewertungskriterium, 2 Arbeitsauftrag, 3 Sachverhalt, 4 bewertete Antwort, 5 Musterlösung.

Quelle und Lizenz: Adapted from the BenGER benchmark dataset, ZJS subset, licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Source dataset: https://huggingface.co/datasets/SebastianNagl/benger. Original ZJS provenance: Wiss. Mitarbeiter Paul Bidmon, Stud. Hilfskraft Nele Walther, Stud. Hilfskraft Hannah Wischmann, Bochum, Anfängerhausarbeit: „Wie du mir, so ich dir“, ZJS_2024_4_S735. The source record is marked ip_cleared=true. Changes were made to convert the case to the LAB-EU task format.

1 Bewertungskriterium

Gleichheitsrechtliche Geeignetheit trotz Opt-out

ERFÜLLT, wenn die Antwort die Differenzierung nach der Spendenbereitschaft als zur Vergrößerung des Spenderpools geeignet einordnet und erklärt, weshalb ein möglicher späterer Widerruf angesichts der verbreiteten Spendenbefürwortung und der Unvorhersehbarkeit des Todes die erwartbare Anreizwirkung nicht entfallen lässt. NICHT ERFÜLLT, wenn die Widerrufsmöglichkeit ohne Prognose als Beweis vollständiger Untauglichkeit behandelt wird.

2 Arbeitsauftrag

So steht der Auftrag in der Aufgabe der Studie:

Bearbeiten Sie den Fall gutachterlich. Erstellen Sie eine vollständige Falllösung auf Grundlage des Sachverhalts in documents/sachverhalt.md.

3 Sachverhalt

Sachverhalt

Sachverhalt Bundesgesundheitsminister B ist ernüchtert, als er im Januar 2023 erfährt, dass laut der Deutschen Stiftung Organspende (DSO), der Koordinierungsstelle gem. § 11 Abs. 1 TPG, die Zahl der Organspenden weiter stagniert. Trotz der Einführung des Gesetzes zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende im Jahr 2019 und der Einführung der Entscheidungslösung im Jahr 2021 konnte die Anzahl der Organtransplantationen bei gleichbleibend hohem Bedarf nicht gesteigert werden. Mit der Entscheidungslösung wurde an dem Grundsatz festgehalten, dass eine Organspende nur durchgeführt wird, wenn der Spender seine Bereitschaft hierzu ausdrücklich erklärt hat. Bestrebungen zur Einführung der sog. Widerspruchslösung, wonach eine Spende bei ausbleibendem Widerspruch stets zulässig wäre, war im Jahr 2021 zugunsten der Entscheidungslösung gescheitert. Die Entscheidungslösung sieht in ihrer 2021 verabschiedeten Form insbesondere vor, dass die Bevölkerung in den Ausweisstellen Informationsmaterialien erhält, Ärzte Beratungsgespräche anbieten können und Grundwissen zur Organspende in Erste-Hilfe-Kurse integriert werden soll. B fühlt sich bestätigt, dass diese „lasche Regelung“ ein „großer Fehler“ war. B ist vor allem über die anhaltende „Trittbrettfahrerei“ von Bürgerinnen und Bürgern empört: Während nach wissenschaftlichen Erkenntnissen im Jahr 2022 84 % eine Organspende befürworten, hätten nur 40 % der Bevölkerung ihre Entscheidung auch dokumentiert. Im Falle der eigenen Erkrankung und eines daraus folgenden Organversagens würden hingegen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nur weniger als 10 % der Betroffenen ein Spenderorgan ablehnen. Diese Diskrepanz ist aus Sicht des B ein „alarmierendes Zeichen fehlender gesellschaftlicher Solidarität“. Gleichwohl hält er es nicht für denkbar, dass der Bundestag zwei Jahre nach der Entscheidung gegen die Widerspruchslösung nun eine solche befürworten würde. Er berät sich deshalb mit Parteikollegin P dazu, wie man Anreize für eine Erhöhung der Organspendenbereitschaft schaffen könnte, die keine Verwerfung der Entscheidungslösung bedürfen und

dennoch „endlich dem Sterben auf der Warteliste ein Ende setzen“. Tatsächlich starben 2022 nach Zahlen der DSO 743 Menschen auf den Wartelisten für Organe. Ziel soll es sein, „gesellschaftliche Solidarität und Spenderzahlen zu erhöhen“. P schlägt vor, eine „Solidaritätsregel“ in das Transplantationsgesetz (TPG) aufzunehmen. Danach sollen Personen, die sich für eine Organspende entscheiden, im Falle eines eigenen Organversagens bevorzugt werden. Die Priorisierung könne in zweierlei Hinsicht erfolgen: Einerseits durch eine Zuordnung sog. „Zusatzpunkte“ für die Wartelisten gem. § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2, 5 TPG in einem Umfang, der die Wartezeit um 50 % verkürzt, was aus ihrer Sicht ein starker Anreiz wäre. Zum anderen soll bei gleicher Priorität von Wartelistenpatienten derjenige den Vorzug erhalten, der sich seinerseits zuvor für eine Organspende entschieden hat. Bisher werden Organe nach den Richtlinien zur Wartelistenführung zunächst anhand organspezifischmedizinischen Kriterien, dann nach der Transportentfernung und zuletzt nach der Wartezeit vergeben. B ist von dem Vorschlag angetan. Wer solidarisch handle, dem solle auch die Solidarität der Bevölkerung zukommen. Die „Doppelmoral“ vieler Bürger müsse ein Ende haben. Es solle sich, so B, vielmehr lohnen, Organe zu spenden. B hat jedoch zunächst noch einige Bedenken: Einerseits müsse jeder die Möglichkeit haben, sich informiert zu entscheiden. Man brauche zudem sicher ein Verfahren und eine Wartezeit. So bedürfe es auch einer Regelung, bis wann man sich entscheiden könne: Denn vielfach würden Patienten im Zeitpunkt der eigenen Organbedürftigkeit aufgrund starker Medikation, insbesondere der Einnahme von Immunsuppressiva, selbst nicht mehr als Organspender in Betracht kommen. Würde man zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung für die Organspende noch einbeziehen, würde dies den Gedanken der Regelung „ad absurdum“ führen. Dies berücksichtigend erstellen B und P einen Gesetzentwurf mit dem Titel „Gesetz zur Stärkung der Solidarität in der Organspende“, kurz GSSO. Das Gesetz regelt eine Ergänzung des Transplantationsgesetzes: Art. 1 GSSO (Alle Ergänzungen kursiviert) § 12 Abs. 3 TPG wird wie folgt um zwei Sätze ergänzt: Die vermittlungspflichtigen Organe sind von der Vermittlungsstelle nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, insbesondere nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit für geeignete Patienten zu vermitteln. Bei der Wartelistenführung werden die Wartelistenpunkte von Personen, die mindestens sechs Monate vor Aufnahme auf die Warteliste ihre Bereitschaft zu einer postmortalen Spende zumindest eines Organs nach den Vorgaben des Absatz 3a erklärt haben, um den Faktor 1,5 multipliziert. Ist bei der Entscheidung nach den Richtlinien über die Wartelistenführung die Wartezeit entscheidend und hat nur ein Patient zum gemäß § 2 GSSO festgelegten Stichtag seine Bereitschaft zur Spende zumindest eines Organes erklärt, so wird dieser unbeschadet seiner Wartezeit vorgezogen. Die Wartelisten […]. Art. 2 GSSO In § 12 TPG wird ein Absatz 3a eingefügt, der wie folgt lautet: Die Bereitschaft zur Spende im Sinne des Absatz 3 Satz 2 ist gegenüber einem Hausarzt nach vorheriger Aufklärung gemäß § 2 Abs. 1a TPG schriftlich zu erklären. Die Priorisierung i.S.d. Abs. 3 S. 2 erfolgt unabhängig einer Erklärung der Bereitschaft zur Spende auch, wenn 1. der Patient vor dem 1. Juli 2024 auf die Warteliste aufgenommen wurde, oder 2. der Patient im Zeitpunkt der Aufnahme auf die Warteliste das 17. Lebensjahr nicht vollendet hat, oder 3. sich der Patient sechs Monate vor Aufnahme auf die Warteliste in einem Zustand der Einwilligungsunfähigkeit befand, oder 4. ein Patient aufgrund dauerhaft bestehender, medizinischer Gründe keine Organe spenden kann. Die Änderung des TPG durch das GSSO wird im Bundestag mit knapper Mehrheit beschlossen und tritt am 1.7.2023 formell ordnungsgemäß in Kraft. In der Diskussion hatten einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier verfassungsrechtliche Bedenken erhoben. Die Neuregelung des § 12 Abs. 3 TPG verenge den „Schutz des Staates für kranke Menschen“ auf einen Schutz von „kranken Menschen einer erwünschten Moral und Weltanschauung“. Es sei das Recht jedes Einzelnen, zu bestimmen, ob sein Körper der Organspende zur Verfügung stehe. Der Körper gehöre keineswegs dem Staat – eine staatliche Disposition darüber sei grundrechtswidrig. Die Regelung zwinge zwar nicht zur Organspende, führe aber zu einem faktischen Zwang, sich zur Organspende bereit zu erklären. Das zudem auch Minderjährigen zuzumuten, könne nicht angehen. Sie müssten gänzlich exkludiert und eine Übergangsfrist nach Eintritt der Volljährigkeit gewährleistet sein. Durch die Priorisierung von Spendenwilligen würden zudem Spendenunwillige zwangsläufig „auf die hintersten Plätze“ geschoben, auf denen ein Tod auf der Warteliste besonders wahrscheinlich sei. Zwar würden Patientinnen und Patienten, was zutrifft, bei einer besonders hohen Dringlichkeit (sog. „High Urgency“, „HU“) auch weiterhin gemäß den Richtlinien der Bundesärztekammer gem. § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2, 5 TPG bevorzugt behandelt. Eine Organvermittlung als „HU“ sei jedoch immer nur ultima ratio, womit Patientinnen und Patienten mit diesem Status in der Regel bereits sehr lange auf ein Organ warten und sich regelmäßig in einem dramatisch schlechten Körperzustand befänden. Vielfach erreichten, – was ebenfalls zutrifft – Patientinnen und Patienten dieses Stadium schon deshalb nicht, weil vorher Kontraindikationen eintreten, die einer Organübertragung entgegenstünden. Damit seien spendenunwillige Personen „dem Tod geweiht“. Einer vermeintlichen Trittbrettfahrermentalität könne mit dem Gesetz ohnehin nicht entgegengewirkt werden, da die Möglichkeit bestehe, dass Personen zunächst ihre Bereitschaft erklärten, dann aber im hohen Alter oder in Erwartung des eigenen Todes ihre Zustimmung widerrufen. Das sieht auch die 16-jährige J so, die in der Presse von dem neuen Gesetz erfährt. Ihr Vertrauen in Staat und Ärzteschaft ist gering. J ist der Meinung, dass das Gesetz in unzumutbarer Weise Druck ausübt, sich für eine Organspende zu entscheiden. Sie habe sich selbst noch nicht entschieden, ob sie Organe spenden wolle. So

werde aber die freie Entscheidung darüber, Organe der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, unzumutbar beeinflusst. Jeder Mensch sei „gleich viel wert“, ganz unabhängig davon, ob er Organe spende. Der Staat müsse deshalb auch alle Menschen gleichermaßen schützen. Stattdessen habe die Politik eine Priorisierung massiven Ausmaßes „aus der Luft gegriffen“. Niemand verstehe, weshalb Spendenwillige ausgerechnet 50 % mehr wert seien. Den Argumenten der kritischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier schließt sie sich an. Sie ist der Überzeugung, es müsse jetzt etwas getan werden, um dieses „Unrecht“ noch rechtzeitig zu verhindern. Ob aus den Reihen des Bundestages gegen das Gesetz vorgegangen werde, wolle sie nicht abwarten. Zusammen mit ihrer 45-jährigen Tante T, die streng religiös lebt, erhebt J deshalb jeweils form- und fristgemäß eine Verfassungsbeschwerde gegen die „neuen Regeln aus dem TPG“, in der die beiden die Argumentation der Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie ihre eigenen Argumente vorbringen. T ist von einem Leben nach dem Tod an der Seite Gottes überzeugt. Sie interpretiert die Bibel dahingehend, dass „die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi Beweis genug dafür ist, dass der Mensch als Ganzes weiterlebe.“ Sie ist dabei sicher, dass ein solches Fortleben ohne ihre Organe nicht denkbar ist. Dass ihr Glaube die Organspende nicht zulasse, der Annahme eines Organs jedoch keine Bedenken gegenüberstehen, sei keine Doppelmoral. Denn maßgeblich sei allein, dass sie als „vollständiger Mensch“ sterbe und „Gott begegne“. Wenn andere Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre Organe hingegen auf Grundlage anderer Überzeugungen im Falle ihrer Erkrankung an sie spendeten, sei dies ein „großes Geschenk“. Sie jedoch könne dies nicht. Wenn nun der Gesetzgeber, so meint T, ihre Überlebenschancen im Falle eines Organversagens so drastisch reduziere, werde sie gezwungen, sich zwischen ihrer Religion und dem Schutz ihrer Gesundheit zu entscheiden. Das stünde ihr aber nicht frei: Das „Wort Gottes“ gelte für sie, seit sie denken könne. Auch in Ansehung der „massiven Nachteile“ sei es ihr unmöglich, ihren Glauben „zu opfern“. Dass sie durch den Staat in diese Lage versetzt werde, sei mit Grundrechten unvereinbar. Sie werde hierdurch gegenüber Andersgläubigen und Atheisten zudem benachteiligt. B, der mittlerweile durch die Medien von den erhobenen Verfassungsbeschwerden erfahren hat, äußert sich in einer Talkshow zu den Vorwürfen der Verfassungswidrigkeit. Er sei erstaunt, dass sich wieder einmal die beschweren, die „weder den Klinikalltag kennen noch auf der Warteliste stehen und etwa auf eine Dialysemaschine angewiesen sind“. Aus ihrer Position sei Kritik leicht geäußert. Er stört sich auch an der Glaubensinterpretation der T und ihrer Sympathisantinnen und Sympathisanten, die aus seiner Sicht nur vorgeschoben sei: Die großen christlichen Kirchen lehnten, was zutrifft, Organspenden keineswegs kollektiv ab. Es könne „nicht jeder die Bibel interpretieren, wie er wolle“, nur um „seine fehlende Solidarität vor sich selbst zu rechtfertigen“. Die Priorisierung von Spendenwilligen sei auch kein „Bruch mit der Gleichwertigkeit menschlichen Lebens“. Ohnehin gehe es mit der Organspende um ein Ereignis nach dem Tod. Dass der Einzelne einen Beitrag leisten müsse, um auch etwas zu erhalten, sei dem Gesundheitssystem mit Blick auf die Krankenkassen im Übrigen nicht fremd. Es sei völlig klar, dass der Staat jeden Menschen vor dem Tod auf der Warteliste bewahren wolle. Dabei müsse er aber zwangsläufig eine gewisse Reihenfolge vorgeben, die auch berücksichtigen könne, wer „den Mangel verursache, der zu dieser Verteilungsproblematik führt“. Die Ausgestaltung dieser Reihenfolge stünde der Legislative zu. Auch das Argument, es könne weiterhin zu „Trittbrettfahrerei“ kommen, überzeugt B nicht. Zum einen sei der eigene Tod vielfach nicht vorhersehbar, zum anderen sei ein „solch kollektives Fehlverhalten“ nicht zu erwarten. Denn wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Spendenbereitschaft zeigten, seien ja viele Bürgerinnen und Bürger bereit, zu spenden – sie müssten dazu aber auch „effektiv bewegt werden“. Die Sorge vor dem eigenen Nachteil werde viele Menschen zu der Einsicht bewegen, ihre Bereitschaft dauerhaft zu manifestieren, so B. Den Verfassungsbeschwerden spricht er nach alledem keine Erfolgschancen zu. Fallfrage Haben die von J und T gemeinsam eingereichten Verfassungsbeschwerden gegen § 12 TPG in seiner durch das GSSO geänderten Fassung Aussicht auf Erfolg? Aus der Zulässigkeit ist allein die Beschwerdebefugnis zu prüfen. Bearbeitungsvermerk Es ist auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen, ggf. hilfsgutachtlich, einzugehen. Bearbeitungszeitpunkt ist der 1. Juli 2023. Andere als die im Sachverhalt oder Bearbeitungsvermerk erwähnten Normen des Transplantationsgesetzes (TPG) sind nicht zu beachten, wobei von ihrer Verfassungsmäßigkeit auszugehen ist (dies gilt nicht für die durch das GSSO neu eingefügten Regelungen in § 12 TPG). Auf die Lebendorganspende gem. § 8 TPG ist nicht einzugehen. Die Richtlinien der Bundesärztekammer gem. § 16 Abs. 1 S. 1 TPG sind nur insoweit einzubeziehen, als sie im Sachverhalt beschrieben sind. Auch von ihrer Verfassungsmäßigkeit ist auszugehen. Gehen Sie weiter davon aus, dass für alle organbezogenen Wartelisten eine Priorisierung im Wege eines Punktesystems erfolgt. Auf § 2 Abs. 1a TPG wird hingewiesen. Auf Regelungen der Sozialgesetzbücher ist nicht einzugehen. Ob B durch seine öffentlichen Äußerungen gegen Pflichten aus der Verfassung verstößt, ist nicht zu prüfen. Eine Verletzung der Beschwerdeführerinnen in ihrem Grundrecht aus Art. 14 GG ist nicht zu prüfen.

4 Bewertete Antwort

Antwort eines der KI-Systeme der Studie. Links die Zeilennummer in der Antwortdatei, Leerzeilen sind mitgezählt, aber nicht gedruckt.

Falllösung

Die von J und T erhobenen Verfassungsbeschwerden haben Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet sind. Da nach dem Bearbeitungsvermerk aus der Zulässigkeit allein die Beschwerdebefugnis zu prüfen ist, ist im Übrigen von der Zulässigkeit der Beschwerden auszugehen.

A. Beschwerdebefugnis

J und T müssten gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG behaupten können, durch die angegriffenen Regeln selbst, gegenwärtig und unmittelbar in einem Grundrecht oder grundrechtsgleichen Recht verletzt zu sein. Eine Verletzung darf nach ihrem Vortrag jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen sein.

Gegenstand der Beschwerden sind bei sachgerechter Auslegung nicht der unverändert gebliebene § 12 Abs. 3 Satz 1 TPG und auch nicht sonstige Vorschriften des TPG. Angegriffen sind vielmehr § 12 Abs. 3 Sätze 2 und 3 TPG sowie der diese Regeln ergänzende § 12 Abs. 3a TPG in der durch das GSSO geschaffenen Fassung.

I. Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung

1. J

J beanstandet, durch die Aussicht auf eine wesentlich ungünstigere Position auf einer künftigen Warteliste zu einer Entscheidung für die postmortale Organspende gedrängt zu werden. Damit erscheint zunächst eine Verletzung ihres Rechts auf personale Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG möglich. Dieses schützt auch die freie Entscheidung darüber, ob der eigene Körper nach dem Tod zur Organentnahme zur Verfügung stehen soll. Da die Neuregelung die Chancen auf den Erhalt eines möglicherweise lebensrettenden Organs verändert, kommen ferner Verletzungen des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG sowie des allgemeinen Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG in Betracht.

Dem steht § 12 Abs. 3a Satz 2 Nr. 2 TPG nicht entgegen. Danach erhält ein Patient den Punktemultiplikator zwar unabhängig von einer Spendeerklärung, wenn er bei Aufnahme auf die Warteliste das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Ausnahme bezieht sich ihrem eindeutigen Wortlaut nach aber nur auf die Priorisierung in § 12 Abs. 3 Satz 2 TPG, nicht auf den zusätzlichen Vorrang nach Satz 3. Außerdem verliert J die Begünstigung aus Satz 2 mit Vollendung des 17. Lebensjahres. Soll sie unmittelbar danach dessen Voraussetzungen erfüllen, muss sie die Spendeerklärung wegen der Sechsmonatsfrist bereits als Minderjährige abgeben. Auch die allgemeine Übergangsregel des § 12 Abs. 3a Satz 2 Nr. 1 TPG erfasst nur Satz 2 und nur eine Aufnahme auf die Warteliste vor dem 1. Juli 2024. Eine grundrechtlich erhebliche Lenkung ihrer Entscheidung ist daher möglich.

2. T

Für T kommen aus denselben Gründen Verletzungen aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG in Betracht. Darüber hinaus beruht ihre Ablehnung einer postmortalen Organspende auf ihrer religiösen Vorstellung, nur als körperlich vollständiger Mensch Gott begegnen zu können. Es erscheint deshalb möglich, dass sie durch den staatlich erzeugten Entscheidungsdruck in ihrer Glaubensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verletzt wird. Weil T außerdem geltend macht, gerade aufgrund ihres Glaubens gegenüber Andersgläubigen und Atheisten benachteiligt zu werden, ist auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG nicht von vornherein ausgeschlossen.

II. Eigene, gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit

J und T sind selbst betroffen. Die Regeln richten sich zwar nicht namentlich an sie, erfassen aber alle potenziellen Empfänger vermittlungspflichtiger Organe und damit auch beide Beschwerdeführerinnen. Sie können ihre eigenen Grundrechte geltend machen.

Fraglich ist, ob die Betroffenheit schon gegenwärtig ist, obwohl weder J noch T erkrankt oder auf einer Warteliste eingetragen ist. Eine bloß irgendwann mögliche Erkrankung würde für sich genommen noch keine gegenwärtige Betroffenheit begründen. Die angegriffene Regel erschöpft sich jedoch nicht in einer erst bei späterer Wartelistenaufnahme eintretenden Punktevergabe. Der Punktemultiplikator setzt grundsätzlich eine mindestens sechs Monate vor Aufnahme auf die Warteliste abgegebene Erklärung voraus. Wer

erst bei Eintritt eines Organversagens entscheidet, kann den Nachteil regelmäßig nicht mehr vermeiden. Die Vorschriften sollen nach der erklärten Konzeption des Gesetzes gerade schon jetzt die Entscheidung potenzieller Organempfänger lenken. Spätestens bis zum 1. Januar 2024 müssen J und T eine Erklärung abgegeben haben, um bei einer Aufnahme ab dem 1. Juli 2024 ohne zeitliche Lücke die Voraussetzungen des Multiplikators zu erfüllen. Der Vorrang aus § 12 Abs. 3 Satz 3 TPG knüpft seinerseits an die Erklärung zu dem gesetzlich bestimmten Stichtag an und wird von den Ausnahmen des Abs. 3a Satz 2 nicht erfasst. Bei J kommt hinzu, dass sie die Erklärung für den Multiplikator gegebenenfalls noch vor Vollendung des 17. Lebensjahres treffen muss. Die mit den Normen bezweckte Entscheidungs- und Drucksituation besteht somit bereits gegenwärtig. Würde Rechtsschutz bis zum Eintritt eines Organversagens versagt, könnten beide die maßgeblichen Vorbedingungen nicht mehr rechtzeitig erfüllen und müssten gerade den geltend gemachten Nachteil hinnehmen.

29 Die Betroffenheit ist auch unmittelbar. Die gegenwärtige Lenkungswirkung tritt ohne weiteren Vollzugsakt ein. Zwar setzt die spätere Veränderung der Rangstelle eine Wartelistenaufnahme und eine konkrete Organvermittlung voraus. Weder die Ärzte noch die Vermittlungsstelle können dann aber nach eigenem Ermessen von dem gesetzlichen Multiplikator oder dem Vorrang abweichen. Den Beschwerdeführerinnen ist es wegen der möglicherweise irreversiblen und lebensgefährlichen Folgen zudem nicht zuzumuten, zunächst eine konkrete Organvergabe abzuwarten.

31 J und T sind folglich beschwerdebefugt. Da nach dem Bearbeitungsvermerk die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht zu untersuchen sind, sind ihre Verfassungsbeschwerden zulässig.

33 ## B. Begründetheit

35 Die Verfassungsbeschwerden sind begründet, soweit § 12 Abs. 3 Sätze 2 und 3 in Verbindung mit Abs. 3a TPG J oder T in einem ihrer Grundrechte verletzt. Das GSSO ist nach dem Sachverhalt formell ordnungsgemäß zustande gekommen. Zu prüfen ist daher allein seine materielle Verfassungsmäßigkeit.

37 ### I. Recht auf personale Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG

39 #### 1. Schutzbereich

41 Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt die engere persönliche Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer Grundbedingungen. Dazu gehört das Recht, in höchstpersönlichen Angelegenheiten selbstbestimmt zu entscheiden. Die Entscheidung, ob nach dem eigenen Tod Organe entnommen und anderen Menschen übertragen werden dürfen, betrifft das Verhältnis der Person zu ihrem Körper, ihre Vorstellung vom eigenen Tod und gegebenenfalls ihre religiöse oder weltanschauliche Identität. Sie ist deshalb eine höchstpersönliche Entscheidung. Geschützt sind sowohl die Zustimmung als auch die Ablehnung. Der Staat darf grundsätzlich auch nicht erzwingen, dass eine noch unentschlossene Person die Frage zu einem von ihm bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Sinne beantwortet. Als Ausprägung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung ist außerdem grundsätzlich selbst zu bestimmen, ob und wem die eigene Spendeentscheidung offenbart wird.

43 Dass die Organentnahme erst nach dem Tod erfolgen soll, beseitigt den Schutz nicht. Gegenstand ist die zu Lebzeiten ausgeübte Selbstbestimmung über den späteren Umgang mit dem eigenen Körper. Dagegen ist die künftige Entnahme als solche nicht unmittelbar am Recht auf körperliche Unversehrtheit des dann Verstorbenen aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zu messen. Der grundrechtliche Schutz der gegenwärtigen Entscheidung folgt vielmehr aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG.

45 J hat sich noch nicht entschieden und kann sich auf ihre Entscheidungsfreiheit berufen. T hat sich aus religiösen Gründen gegen eine Organspende entschieden; auch diese negative Entscheidung fällt in den Schutzbereich.

47 #### 2. Eingriff

49 Die neuen Vorschriften verpflichten niemanden unmittelbar, einer Organspende zuzustimmen. Auch bleibt eine einmal abgegebene Spendeerklärung grundsätzlich widerruflich. Ein Grundrechtseingriff kann jedoch ebenfalls in einer mittelbaren oder faktischen staatlichen Maßnahme liegen, wenn ihre belastende Wirkung dem Staat zurechenbar ist und sie nach Zielsetzung und Gewicht einem rechtlichen Zwang nahekommt.

51 Nach § 12 Abs. 3 Satz 2 TPG werden die Wartelistenpunkte einer Person, die mindestens sechs Monate vor der Wartelistenaufnahme nach § 12 Abs. 3a Satz 1 TPG ihre Spendenbereitschaft erklärt hat, mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Nach § 12 Abs. 3 Satz 3 TPG erhält die erklärungsbereite Person außerdem den Vorrang, wenn auf der letzten Stufe der Verteilungsentscheidung die Wartezeit maßgeblich ist. Wegen des absoluten Organmangels verbessert jede solche Begünstigung notwendig die Überlebenschance des einen auf Kosten des anderen Patienten. Nach den Angaben im Sachverhalt kann ein zurückgesetzter Patient

versterben oder wegen zwischenzeitlich eingetretener Kontraindikationen seine Transplantationsfähigkeit verlieren, bevor er den Status „High Urgency“ erreicht. Die Alternative zur Spendeerklärung ist daher nicht nur der Verzicht auf einen beliebigen staatlichen Vorteil, sondern die Inkaufnahme einer erheblich verminderten Chance auf eine lebensrettende Behandlung.

53 Diese Wirkung ist kein unbeabsichtigter Reflex. Das Gesetz soll die Bevölkerung gerade aus Sorge vor eigenen Nachteilen „effektiv“ zu mehr Spendeerklärungen bewegen. Es setzt damit einen zielgerichteten und außerordentlich gewichtigen Anreiz. Dieser greift in die freie Entscheidung von J und T ein. Weil § 12 Abs. 3a Satz 1 TPG für den Vorteil eine schriftliche Erklärung gegenüber einem Hausarzt nach vorheriger Aufklärung verlangt und die Erklärung für die spätere Priorisierung nachweisbar sein muss, erstreckt sich die Lenkungswirkung auch auf die Offenbarung dieser sensiblen persönlichen Information. Dies berührt insbesondere Js ausdrücklich geringes Vertrauen in Staat und Ärzteschaft, hängt aber nicht von einer besonderen Begründung ihres Misstrauens ab.

55 Die Ausnahmen in § 12 Abs. 3a Satz 2 TPG beseitigen den Eingriff nicht. Sie gewähren vor dem 1. Juli 2024 aufgenommenen Patienten, noch nicht 17-jährigen Patienten, schon sechs Monate vor Wartelistenaufnahme Einwilligungsunfähigen sowie dauerhaft medizinisch spendeunfähigen Personen den Multiplikator auch ohne Erklärung. T fällt in keine dieser Gruppen. J erhält diesen Schutz nur, solange sie vor ihrem 17. Geburtstag auf die Warteliste aufgenommen wird; gerade die Sechsmonatsfrist kann von ihr eine Erklärung noch während ihrer Minderjährigkeit verlangen. Überdies gelten sämtliche Ausnahmen nach ihrem Wortlaut nur für § 12 Abs. 3 Satz 2 TPG. Vom Vorrang nach Satz 3 bleiben J und die anderen ausgenommenen Personen ohne Spendeerklärung ausgeschlossen.

57 **3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung**

59 Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist nicht vorbehaltlos gewährleistet. Die in Art. 2 Abs. 1 GG genannte verfassungsmäßige Ordnung umfasst formell und materiell verfassungsgemäße Gesetze. Wegen der Nähe der Organspendeentscheidung zur personalen Identität und wegen der existenziellen Folgen des eingesetzten Druckmittels sind an die Verhältnismäßigkeit jedoch strenge Anforderungen zu stellen.

61 **a) Legitimer Zweck**

63 Das Gesetz soll die Zahl dokumentierter Spendeerklärungen und dadurch die Zahl transplantierbarer Organe erhöhen. Damit sollen mehr Erkrankte gerettet und Todesfälle auf Wartelisten vermieden werden. Der Staat verfolgt insoweit den Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit anderer Menschen nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG. Dies ist ein besonders gewichtiger legitimer Zweck.

65 Daneben möchte der Gesetzgeber solidarisches Verhalten honorieren und verhindern, dass Menschen ein Spenderorgan annehmen, obwohl sie selbst keines zur Verfügung stellen wollen. Soweit darin nur eine moralische Missbilligung von „Trittbrettfahrern“ liegt, könnte sie einen Eingriff in eine höchstpersönliche Entscheidung nicht rechtfertigen. Als auf die Erweiterung des knappen Organpools bezogenes Reziprozitätsprinzip kann der Solidaritätsgedanke aber zunächst als legitimer Verteilungszweck berücksichtigt werden.

67 **b) Geeignetheit**

69 Geeignet ist eine Maßnahme, wenn sie den verfolgten Zweck zumindest fördern kann. Die Aussicht auf eine bessere Wartelistenposition schafft einen starken Anreiz, die Spendenbereitschaft zu erklären. Zwar garantiert eine Erklärung keine spätere Organspende. Der Erklärende kann seine Entscheidung ändern, nach einer eigenen Transplantation widerrufen oder im Todeszeitpunkt aus medizinischen Gründen als Spender ungeeignet sein. Auch können Tod und Organentnahme ausbleiben. Diese Einwände schließen jedoch nicht aus, dass eine größere Zahl frühzeitig dokumentierter Einwilligungen im Ergebnis zu mehr realisierten Spenden führt. Dem Gesetzgeber steht bei dieser Prognose ein Einschätzungsspielraum zu. Die Regelung ist daher nicht offensichtlich ungeeignet.

71 **c) Erforderlichkeit**

73 Ein milderes Mittel müsste die Zahl verfügbarer Organe gleich wirksam erhöhen. Beratung, Informationsmaterial, das Organspenderegister und die Einbindung von Erste-Hilfe-Kursen beeinträchtigen die Entscheidungsfreiheit weniger stark. Gerade diese Elemente der Entscheidungslösung haben nach dem Sachverhalt die Spenderzahlen bislang aber nicht erhöht. Ein ausschließliches Vorrangrecht bei ansonsten völlig gleichem Rang wäre ebenfalls weniger belastend, erzeugte aber voraussichtlich einen schwächeren Anreiz als der zusätzliche Punktemultiplikator. Die Widerspruchslösung wäre anders ausgestaltet, griffe ihrerseits tief in die Entscheidungsfreiheit ein und ist nicht zweifelsfrei ein milderes, gleich wirksames Mittel. Angesichts des gesetzgeberischen Prognosespielraums kann die Erforderlichkeit der Regelung daher noch angenommen werden.

d) Angemessenheit

Die Belastung der Betroffenen dürfte schließlich nicht außer Verhältnis zum Gewicht und zur Dringlichkeit der verfolgten Zwecke stehen.

Für die Regelung spricht das überragende Gewicht des Lebensschutzes. Im Jahr 2022 starben 743 Menschen auf den Wartelisten. Die Verteilung der nicht für alle Patienten ausreichenden Organe verlangt ohnehin eine Rangfolge. Mit der Sechsmonatsfrist soll verhindert werden, dass ein Patient erst im Angesicht des eigenen Organbedarfs eine für ihn risikolose Spendeerklärung abgibt. Die verpflichtende ärztliche Aufklärung nach § 12 Abs. 3a Satz 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1a TPG und die Härtefallausnahmen vermindern zudem das Risiko einer uninformierten oder objektiv unmöglichen Entscheidung. Wäre die Priorisierung als solche zulässig, wären die schriftliche Dokumentation gegenüber einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Arzt und ihre Verwendung zum Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen grundsätzlich geeignete und erforderliche Formen der Datenverarbeitung.

Dem steht jedoch eine außergewöhnlich schwere Belastung gegenüber. Ein nicht spendenbereiter Patient verliert nicht nur einen finanziellen Vorteil. Er wird innerhalb eines staatlich geregelten Verfahrens zur Verteilung lebensrettender Organe zurückgesetzt. Der Punktemultiplikator von 1,5 kann seine Wartezeit nach der Konzeption des Gesetzes erheblich verlängern. Auch der Vorrang nach § 12 Abs. 3 Satz 3 TPG verdrängt die sonst maßgebliche längere Wartezeit. Der fortbestehende HU-Vorrang kompensiert dies nicht. HU ist nach dem Sachverhalt nur eine ultima ratio in bereits dramatisch schlechtem Gesundheitszustand. Manche Patienten werden wegen eintretender Kontraindikationen gar nicht mehr für eine Transplantation in Betracht kommen. Die Nachteile können daher zum Tod führen.

Zugleich ist der Zusammenhang zwischen dem auferlegten Nachteil und einem eigenen Beitrag zum Organpool nur begrenzt. Privilegiert wird bereits die Bereitschaft zur Spende mindestens eines Organs, unabhängig davon, welches Organ der Erklärende später selbst benötigt, wie viele Organe er freigibt und ob es jemals zu einer verwertbaren Spende kommt. Die Erklärung bleibt Ausdruck persönlicher Selbstbestimmung und darf deshalb nicht unwiderruflich gemacht werden. Gerade die gebotene Widerruflichkeit verhindert aber, dass das mit dem existenziellen Vorteil belohnte Verhalten einen entsprechenden Beitrag sicherstellt. Wer nach einer eigenen Transplantation seine Einwilligung widerruft, hat den Vorteil erhalten, ohne später zur Vergrößerung des Organpools beizutragen. Umgekehrt „verursacht“ ein Mensch den Organmangel nicht schon dadurch in rechtlich zurechenbarer Weise, dass er eine ihm grundrechtlich freistehende Organspende ablehnt.

Vor allem verlässt die Regelung die medizinischen Kriterien der Dringlichkeit und Erfolgsaussicht und knüpft Überlebenschancen an ein vom Staat als solidarisch bewertetes Verhalten. Der Staat darf über Information und Beratung zu Spenden ermutigen. Er darf die freie Zustimmung aber nicht dadurch herbeiführen, dass er für den Fall einer späteren lebensgefährlichen Erkrankung mit einer erheblichen Verschlechterung der Rettungschancen droht. Die vermeintliche Freiwilligkeit wird entwertet, wenn die Alternative in der Inkaufnahme eines erhöhten Todesrisikos besteht. Die pauschale Erhöhung um 50 Prozent verschärft dieses Problem; ein sachlicher Grund gerade für dieses Ausmaß ist nicht ersichtlich.

Bei J wirkt die Regelung zudem schon auf die Entscheidung einer Minderjährigen ein. Die Neuregelung setzt zwar ersichtlich voraus, dass eine Spendeerklärung schon vor Vollendung des 17. Lebensjahres abgegeben werden kann. Daraus folgt aber nicht, dass der Gesetzgeber eine entsprechende Entscheidung mit einem existenziellen Nachteil erzwingen darf. § 12 Abs. 3a Satz 2 Nr. 2 TPG gewährt den Multiplikator ohne Erklärung nur Personen, die bei Wartelistenaufnahme noch keine 17 Jahre alt sind. Wegen der sechsmonatigen Vorfrist muss ein Jugendlicher, der ab dem 17. Geburtstag lückenlos geschützt sein will, bereits mit 16 Jahren erklären. Eine Übergangsfrist, die eine unbeeinflusste Entscheidung nach Erreichen der Volljährigkeit ermöglicht, fehlt. Die allgemeine Übergangsregel bis zum 1. Juli 2024 ändert daran dauerhaft nichts. Der Vorrang nach § 12 Abs. 3 Satz 3 TPG ist von der Minderjährigenausnahme überhaupt nicht erfasst.

Bei T zwingt die Regelung zu einer Wahl zwischen einer für sie verbindlichen religiösen Überzeugung und einer erheblich besseren Chance, im Fall eines Organversagens zu überleben. Das verleiht dem Eingriff zusätzliches Gewicht.

Der Gesetzgeber darf Anreize setzen und besitzt bei der Ausgestaltung eines Verteilungssystems Spielraum. Dieser endet aber dort, wo ein höchstpersönliches, grundrechtlich geschütztes Verhalten durch eine massive Verschlechterung der Überlebenschancen erkauft werden soll. Der mögliche Zuwachs an Spendeerklärungen rechtfertigt weder den Faktor 1,5 noch den zusätzlichen Vorrang bei der Wartezeit. Weil die Offenbarung gegenüber dem Hausarzt zwingende Voraussetzung dieses unverhältnismäßigen Anreizsystems ist, kann auch der damit verbundene Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung nicht aufrechterhalten werden. Die Regelungen sind unangemessen.

4. Ergebnis

§ 12 Abs. 3 Sätze 2 und 3 in Verbindung mit Abs. 3a TPG verletzt J und T in ihrem Recht auf personale Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG.

II. Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG

1. Schutzgehalt und Beeinträchtigung

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schützt das Leben und die körperliche Unversehrtheit. Aus dem Grundrecht folgt kein Anspruch auf ein bestimmtes fremdes Organ. Ein solches Organ ist nicht staatlich beliebig verfügbar, und wegen des Mangels kann nicht jeder geeignete Patient transplantiert werden. Hat der Staat jedoch ein rechtlich geordnetes Vermittlungssystem geschaffen, darf er die tatsächliche Chance auf Zugang zu einer lebensrettenden Behandlung nicht durch verfassungswidrige Kriterien verkürzen.

Die gesetzliche Höherstufung Spendenwilliger ist wegen der fixen Zahl verfügbarer Organe zugleich eine Zurückstufung Spendenunwilliger. Diese kann Wartezeiten verlängern, das Eintreten einer Kontraindikation begünstigen und das Todesrisiko erhöhen. Die Beeinträchtigung ist dem Staat unmittelbar zurechenbar. Sie ist deshalb nicht lediglich als Nichterfüllung eines Leistungswunsches, sondern als Eingriff in die durch das bestehende Verteilungssystem vermittelte Lebens- und Gesundheitschance zu beurteilen.

Selbst wenn man einen klassischen Eingriff verneinte, träfe den Staat aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG eine Schutzpflicht für das Leben aller Wartelistenpatienten. Bei ihrer Erfüllung hat er zwar einen weiten Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum. Wegen der Unmöglichkeit, alle Patienten zu retten, ist die Schutzpflicht nicht schon deshalb verletzt, weil eine Person kein Organ erhält. Der Staat darf seine Schutzentscheidung jedoch nicht nach Kriterien treffen, die mit der gleichen Schutzwürdigkeit jedes menschlichen Lebens und den Freiheitsrechten der Betroffenen unvereinbar sind.

2. Rechtfertigung

Der Eingriff dient mit der erwarteten Vergrößerung des Organpools wiederum dem Schutz des Lebens anderer Patienten. Die widerstreitenden Lebensinteressen sind grundsätzlich gleichrangig. Der Gesetzgeber muss deshalb einen Ausgleich schaffen, ohne das Leben der einen Gruppe wegen eines rechtmäßigen höchstpersönlichen Verhaltens geringer zu schützen.

Die Regelung erhält zwar die medizinischen Kriterien des § 12 Abs. 3 Satz 1 TPG und den HU-Vorrang aufrecht. Durch den Faktor 1,5 und den Vorrang auf der Ebene der Wartezeit verändert sie die Rangfolge aber in erheblichem Ausmaß aufgrund eines nichtmedizinischen Verhaltenskriteriums. Die Zurücksetzung dient nicht der besseren Erfolgsaussicht einer konkreten Transplantation. Auch eine individuelle Verantwortlichkeit für den Mangel besteht nicht. Die lediglich mögliche spätere Erweiterung des Organangebots reicht aus den bereits genannten Gründen nicht aus, um einem nicht spendenbereiten Patienten gegenwärtig ein erheblich höheres Risiko des Todes oder des Verlusts seiner Transplantationsfähigkeit aufzuerlegen. Mildere Lenkungsmaßnahmen mögen weniger wirksam sein; der Staat darf den erstrebten Erfolg aber nicht um den Preis einer unverhältnismäßigen Gefährdung der anderen Gruppe erreichen.

Die Beeinträchtigung ist daher nicht angemessen. § 12 Abs. 3 Sätze 2 und 3 in Verbindung mit Abs. 3a TPG verletzt J und T auch in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG.

III. Allgemeiner Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG

1. Ungleichbehandlung

Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches seiner Eigenart entsprechend verschieden zu behandeln. Die angegriffenen Regeln unterscheiden zwischen medizinisch für eine Transplantation geeigneten Wartelistenpatienten danach, ob sie rechtzeitig ihre Bereitschaft zur postmortalen Spende mindestens eines Organs erklärt haben. Bei ansonsten gleicher Punktzahl erhält die erste Gruppe durch Multiplikation ihrer Punkte mit 1,5 einen höheren Rang. Ist die Wartezeit entscheidend, wird sie nach § 12 Abs. 3 Satz 3 TPG ebenfalls vorgezogen. Dies ist eine unmittelbare Ungleichbehandlung.

Weitere Differenzierungen folgen aus § 12 Abs. 3a Satz 2 TPG. Bestimmte Patienten erhalten den Punktemultiplikator auch ohne Erklärung, insbesondere bei einer Wartelistenaufnahme vor dem 1. Juli 2024, vor Vollendung des 17. Lebensjahres, bei rechtzeitiger Einwilligungsunfähigkeit oder bei dauerhafter medizinischer Spendeunfähigkeit. Andere Personen mit einer tatsächlich ebenso fehlenden Möglichkeit zur Organspende oder mit einer grundrechtlich geschützten Ablehnung werden nicht ausgenommen. Selbst die ausdrücklich ausgenommenen Personen werden ohne Erklärung nicht am zusätzlichen Vorrang des § 12 Abs. 3 Satz 3 TPG beteiligt.

2. Verfassungsrechtlicher Maßstab

Die Anforderungen an die Rechtfertigung reichen je nach Regelungsgegenstand vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Strenge Anforderungen gelten, wenn die Differenzierung an Merkmale anknüpft, welche die Person kaum beeinflussen kann, oder wenn sie sich auf die Ausübung von Freiheitsrechten nachteilig auswirkt. Hier beeinflusst die Differenzierung die Chance auf eine lebensrettende Behandlung und setzt die Betroffenen zugleich unter Druck, ihr Selbstbestimmungsrecht, bei T außerdem ihre Religionsfreiheit, in einer bestimmten Weise auszuüben. Daher ist eine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung geboten.

3. Rechtfertigung der Differenzierung nach der Spendenbereitschaft

Als Differenzierungsziele kommen die Vergrößerung des Organangebots und die Honorierung organbezogener Solidarität in Betracht. Beide weisen einen Bezug zur Verteilungssituation auf. Ein völlig sachfremdes Kriterium liegt daher nicht vor. Dass eine dokumentierte Spendenbereitschaft den Organpool möglicherweise vergrößert, genügt aber angesichts der strengen Prüfungsdichte nicht.

Die Vergleichsgruppen sind in Bezug auf den gegenwärtigen Bedarf nach einem lebensrettenden Organ und ihre medizinische Eignung gleich. Der wesentliche Unterschied liegt allein in einer vorgelagerten höchstpersönlichen Entscheidung. Diese Entscheidung ist kein verlässliches Maß für einen tatsächlich erbrachten Beitrag: Die Einwilligung kann widerrufen werden, der Tod kann unter nicht spendefähigen Umständen eintreten und medizinische Gründe können eine Entnahme ausschließen. Die Bereitschaft zu nur einem beliebigen Organ löst bereits den vollen Vorteil aus. Umgekehrt ist derjenige, der aus persönlichen oder religiösen Gründen nicht einwilligt, nicht für die konkrete Knappheit eines benötigten Organs verantwortlich.

Das Krankenversicherungssystem, auf das B verweist, ist nicht vergleichbar. Dort werden abstrakt-generelle Finanzierungsbeiträge für ein solidarisches Leistungssystem erhoben. Eine postmortale Organspende betrifft demgegenüber die höchstpersönliche Verfügung über den eigenen Körper und kann nicht wie ein Geldbeitrag staatlich verlangt werden. Aus der Bereitschaft, ein fremdes Organ anzunehmen, folgt deshalb keine rechtliche Pflicht, den eigenen Körper nach dem Tod ebenfalls zur Verfügung zu stellen.

Vor allem steht das Ausmaß der Ungleichbehandlung außer Verhältnis zum nur möglichen Beitrag. Der Faktor 1,5 kann medizinisch vergleichbare Patienten weit auseinanderziehen. Der zusätzliche Vorrang kann eine längere Wartezeit überspielen. Wegen der möglichen Folgen bis hin zum Tod bedürfte eine solche Differenzierung eines besonders tragfähigen Grundes. Die moralische Bewertung als „solidarisch“ oder „unsolidarisch“ reicht dafür nicht aus. Auch die erhoffte mittelbare Erhöhung des Gesamtaufkommens legitimiert es nicht, die gleiche Schutzwürdigkeit des konkreten Lebens durch ein nichtmedizinisches Verhaltenskriterium zu überlagern. Warum gerade eine Erhöhung um 50 Prozent erforderlich und sachgerecht sein soll, ist zudem nicht erkennbar.

Die Differenzierung nach der Spendenbereitschaft ist somit unangemessen und verletzt Art. 3 Abs. 1 GG.

4. Altersbezogene Regelung bei J

Unabhängig davon ist zu untersuchen, ob J durch die Altersgrenze des § 12 Abs. 3a Satz 2 Nr. 2 TPG eigenständig gleichheitswidrig benachteiligt wird. Die Vorschrift behandelt Patienten, die bei Wartelistenaufnahme noch nicht 17 Jahre alt sind, anders als Patienten, die das 17. Lebensjahr gerade vollendet haben. Altersgrenzen dürfen typisieren, wenn sich die Grenze am Regelungszweck orientiert und unvermeidbare Härten nicht übermäßig wiegen.

Die Schonung besonders junger Patienten und die Anknüpfung an eine gesetzlich angenommene wachsende Entscheidungsreife sind legitime Gründe. Die Neuregelung geht erkennbar davon aus, dass eine Erklärung bereits vor Vollendung des 17. Lebensjahres möglich ist. Es ist daher nicht schon als solches gleichheitswidrig, die Ausnahme nicht bis zum 18. Geburtstag auszudehnen. Wegen der sechsmonatigen Vorfrist hat die Altersgrenze aber zur Folge, dass der Multiplikator ab dem 17. Geburtstag nur durch eine Erklärung im Alter von 16 Jahren lückenlos gewahrt werden kann. Die Ausnahme schützt somit nicht bis zu dem Zeitpunkt, in dem eine Entscheidung erst nach Erreichen der Volljährigkeit getroffen werden könnte. Für den zusätzlichen Vorrang nach § 12 Abs. 3 Satz 3 TPG besteht nicht einmal bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres eine Ausnahme.

Ob allein dieser fehlende Übergang die Altersgrenze verfassungswidrig macht, kann offenbleiben. Für eine Rechtfertigung spricht die gesetzgeberische Typisierungsbefugnis. Dagegen sprechen das Gewicht des angedrohten Nachteils, der besondere Schutz Minderjähriger vor einer staatlich gelenkten höchstpersönlichen Entscheidung und die Beschränkung sämtlicher Ausnahmen auf Satz 2. Jedenfalls ist J bereits durch die

allgemeine Differenzierung zwischen rechtzeitig Spendenwilligen und anderen Patienten in Art. 3 Abs. 1 GG verletzt.

147 **IV. Glaubensfreiheit der T aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG**

149 **1. Schutzbereich**

151 Art. 4 Abs. 1 und 2 GG schützt die Freiheit, einen Glauben zu bilden, zu haben, zu äußern und das gesamte Verhalten an den als verbindlich empfundenen Glaubenssätzen auszurichten. Es kommt nicht darauf an, ob die großen christlichen Kirchen die konkrete Glaubensregel teilen. Der Staat darf weder verbindlich auslegen, was die Bibel „richtig" verlangt, noch den Schutz auf allgemein anerkannte Lehrsätze einer Religionsgemeinschaft beschränken. Erforderlich ist nur, dass die Betroffene eine religiöse Überzeugung plausibel darlegt und ihr Verhalten tatsächlich an ihr ausrichtet.

153 T glaubt an ein Leben nach dem Tod und ist überzeugt, Gott nur als körperlich vollständiger Mensch begegnen zu können. Sie leitet daraus ein für sie verbindliches Verbot der Organspende ab. Diese Vorstellung weist einen hinreichenden Bezug zu christlichen Glaubensinhalten auf und wird von T seit langem ernsthaft vertreten. Dass sie die Annahme eines fremden Organs für zulässig hält, nimmt ihrer Überzeugung nicht den religiösen Charakter. Ihre Unterscheidung knüpft daran an, in welchem körperlichen Zustand sie selbst sterben und Gott begegnen werde. Es ist nicht Aufgabe des Staates, diese Glaubensinterpretation auf theologische Folgerichtigkeit zu überprüfen. Der Schutzbereich ist eröffnet.

155 **2. Eingriff**

157 Die Vorschriften verbieten T nicht, an ihrer Überzeugung festzuhalten, und zwingen sie nicht rechtlich zu einer Spendeerklärung. Sie verschlechtern aber gezielt ihre Chancen auf ein lebensrettendes Organ, wenn sie das religiös gebotene Verhalten befolgt. Wegen des Faktors 1,5 und des Vorrangs bei maßgeblicher Wartezeit muss sie zwischen Glaubenstreue und einer erheblich besseren Überlebenschance wählen. Der Staat beabsichtigt gerade, durch diesen Nachteil eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Eine derart zielgerichtete und gewichtige mittelbare Belastung ist ein Eingriff in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG.

159 **3. Rechtfertigung**

161 Die Glaubensfreiheit ist vorbehaltlos gewährleistet. Eingriffe können nur durch kollidierendes Verfassungsrecht gerechtfertigt werden. Als solches kommt der staatliche Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit der auf ein Organ angewiesenen Menschen aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG in Betracht. Zwischen beiden Verfassungsgütern ist im Wege praktischer Konkordanz ein verhältnismäßiger Ausgleich herzustellen.

163 Die Vorschriften können, wie dargelegt, mehr Spendeerklärungen und möglicherweise mehr Spenderorgane bewirken. T wird jedoch nicht zur Abwehr einer von ihr ausgehenden konkreten Gefahr in Anspruch genommen. Vielmehr soll sie eine religiös verbotene Verfügung über ihren Körper treffen, damit ihre eigene Chance auf staatlich organisierte Lebensrettung nicht erheblich vermindert wird. Wegen der Widerruflichkeit und der ungewissen medizinischen Spendefähigkeit steht der schwere Nachteil auch hier keinem sicheren Beitrag zum Schutz anderer gegenüber. Die Ausnahmen des § 12 Abs. 3a Satz 2 TPG erfassen zwar Personen, denen eine Erklärung tatsächlich oder rechtlich unmöglich ist, nicht aber Personen, denen sie aufgrund einer ernsthaften Glaubensüberzeugung unzumutbar ist.

165 Der Staat muss T nicht von jeder allgemeinen Folge ihres Glaubens entlasten. Hier schafft er die existenzielle Folge jedoch selbst und gerade zu dem Zweck, ihre geschützte Entscheidung zu ändern. Eine Einzelfallprüfung der „Richtigkeit" oder Verbreitung ihres Glaubens wäre kein zulässiger Ausweg. Bei der Verteilung lebensrettender Organe müssen deshalb Kriterien gewählt werden, welche die religiöse Ablehnung einer eigenen Organspende nicht mit einer derart massiven Verschlechterung der Überlebenschance sanktionieren. Die Regelung stellt keine praktische Konkordanz her, sondern lässt den Lebensschutz anderer Patienten einseitig zulasten der Glaubensfreiheit von T überwiegen. Der Eingriff ist unangemessen.

167 T ist folglich auch in ihrer Glaubensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verletzt.

169 **V. Benachteiligungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG**

171 T könnte ferner wegen ihres Glaubens benachteiligt sein. § 12 TPG knüpft den Nachteil seinem Wortlaut nach nicht an einen bestimmten Glauben oder an Religiosität an, sondern an das Fehlen einer rechtzeitigen Spendeerklärung. Der Nachteil trifft ebenso Menschen, die eine Organspende aus nichtreligiösen Gründen ablehnen. Zudem ist nach dem Sachverhalt eine Ablehnung der Organspende kein allgemeines Merkmal christlicher Gläubiger; die großen christlichen Kirchen lehnen sie nicht kollektiv ab. Eine gezielte oder typischerweise gerade Religionsangehörige treffende mittelbare Differenzierung lässt sich deshalb nicht feststellen.

173 Dass T aufgrund ihrer individuellen Glaubensüberzeugung den Vorteil nicht in Anspruch nehmen kann, wird vollständig durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG erfasst. Eine zusätzliche Benachteiligung „wegen“ des Glaubens im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG liegt nicht vor.

175 **VI. Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG**

177 J macht geltend, jeder Mensch sei gleich viel wert; auch im parlamentarischen Verfahren wurde eine Auswahl von Menschen nach einer „erwünschten Moral“ beanstandet. Daher ist eine eigenständige Verletzung von Art. 1 Abs. 1 GG zu erwägen.

179 Die Menschenwürde verbietet es, den Menschen zum bloßen Objekt staatlichen Handelns zu machen oder den Wert menschlichen Lebens nach sozialen, moralischen oder anderen persönlichen Merkmalen abzustufen. Die Notwendigkeit, unzureichend vorhandene Organe nach einer Rangfolge zu vergeben, enthält für sich genommen aber noch kein Urteil über den Wert der betroffenen Menschen. Die angegriffenen Vorschriften ordnen keine Organentnahme gegen den Willen an und sprechen Spendenunwilligen nicht ihr Lebensrecht ab. Sie stellen auf eine vom Gesetzgeber für ressourcenbezogen gehaltene Spendenbereitschaft ab und belassen formal eine Wahlmöglichkeit.

181 Damit wird die hohe Schwelle einer Objektivierung oder ausdrücklichen Bewertung menschlichen Lebens nicht überschritten. Die Verwendung des unverhältnismäßigen Verhaltenskriteriums verletzt die spezielleren Gewährleistungen aus Art. 2 und Art. 3 GG, begründet aber nicht zusätzlich eine eigenständige Verletzung des Art. 1 Abs. 1 GG.

183 ## C. Gesamtergebnis

185 J und T sind beschwerdebefugt; ihre Verfassungsbeschwerden sind im Übrigen als zulässig zu behandeln. § 12 Abs. 3 Sätze 2 und 3 in Verbindung mit Abs. 3a TPG verletzt beide Beschwerdeführerinnen in ihrem Recht auf personale Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG, in ihrem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG sowie in Art. 3 Abs. 1 GG. T ist zusätzlich in ihrer Glaubensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verletzt. Eigenständige Verletzungen von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG und Art. 1 Abs. 1 GG liegen dagegen nicht vor.

187 Die Verfassungsbeschwerden von J und T haben somit Aussicht auf Erfolg.

5 Musterlösung

Musterlösung

A. Zulässigkeit

Die Zulässigkeit setzt zunächst die Erfüllung der allgemeinen und besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen voraus, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG.

I. Beschwerdebefugnis

T und J müssten gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG, beschwerdebefugt sein. Dazu müssten beide die Möglichkeit einer qualifizierten Grundrechtsverletzung behaupten können.

1. Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung

Zunächst dürfte die Möglichkeit einer Verletzung von Grundrechten der Beschwerdeführerinnen nicht schlechthin ausgeschlossen sein. T argumentiert, dass § 12 TPG n.F. durch die in Rede stehende Priorisierung von Spendern zu einer Entscheidung für die Organspende dränge, die mit ihrer Glaubensüberzeugung unvereinbar sei. Somit erscheint es nicht ausgeschlossen, dass § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG das Grundrecht der Religionsfreiheit, Art. 4 Abs. 1 Var. 1 GG, der T verletzt. Durch die Gesetzesänderung sehen sich beide Beschwerdeführerinnen gezwungen, sich mit der Entscheidung hinsichtlich des Verfahrens mit ihrem Körper nach dem eigenen Tod zu befassen, womit ein gewisser Entscheidungsdruck hinsichtlich einer persönlichkeitsnahen Entscheidung entstehen kann. So ist es nicht von vornherein auszuschließen, dass T und J hierdurch in ihrem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) verletzt sein könnten. Gleichermaßen ist auch eine Verletzung der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) zumindest denkbar. Weiter werden durch § 12 TPG organspendenbereite Personen priorisiert und somit anders behandelt als Spendenunwillige, denen diese Priorisierung nicht zukommt. Mithin ist auch eine Verletzung des Art. 3 Abs. 1, 3 GG nicht von vornherein ausgeschlossen. Somit besteht die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung bezüglich T und J.

2. Qualifizierte Betroffenheit

T und J müssten weiter qualifiziert, also selbst, gegenwärtig und unmittelbar durch die hoheitliche Maßnahme – § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG als Akt der Legislative – betroffen sein.

a) Selbstbetroffenheit

Selbstbetroffen sind T und J, wenn sie Adressatinnen der Norm sind. § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3 TPG führen zur Priorisierung bei der Organvergabe, wenn die Personen sich zuvor selbst zu einer Organspende bereiterklärt haben, und damit zum Entscheidungsdruck für jeden, der als potenzieller Organspender in Betracht kommt. T ist zur Organspende befugt und fällt nicht unter die Ausnahme des § 12 Abs. 3a S. 2 TPG. Fraglich ist allein, ob auch J aufgrund ihres Alters bereits Adressatin der Norm ist. Wegen der Ausnahmeregelung in Abs. 3a Nr. 2 TPG gelten die gesetzlichen Regelungen erst für Personen, die das 17. Lebensjahr vollendet haben. Zum Zeitpunkt des Eintretens der Wirkung einer Entscheidung und einer entsprechenden Priorisierung am 1.7.2024 ist J 17 Jahre alt und fällt somit auch nicht mehr unter die Ausnahmeregelung des Abs. 3a Nr. 2 TPG. Folglich ist auch J Adressatin der Norm und sowohl T als auch J sind auch selbst betroffen.

b) Gegenwärtigkeit

Zudem müssten T und J gegenwärtig betroffen sein. Dies ist der Fall, wenn der Akt der öffentlichen Gewalt die Beschwerdeführer schon oder noch in eigenen Rechten betrifft. Dazu müsste der Beschwerdegegenstand die Beschwerdeführer bereits jetzt und nicht erst irgendwann in Zukunft betreffen. Ausnahmsweise kann jedoch eine wahrscheinliche, zukünftige Betroffenheit ausreichen, wenn konkret absehbar ist, dass und wie der Beschwerdeführer zukünftig betroffen sein wird. § 12 Abs. 3, 3a TPG ist bereits in Kraft getreten. Problematisch könnte sein, dass zum aktuellen Zeitpunkt weder T noch J ein Spenderorgan benötigen, sodass zumindest die Priorisierung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt. Die Auswirkungen der Bevorteilung oder Benachteiligung im Vergleich zu anderen Personen werden zudem erst dann deutlich, wenn der Adressat ein Spenderorgan benötigt und auf die Warteliste aufgenommen wird. Insoweit ist auch nicht durchschlagend, dass Überlegungen zur Organspende bereits im heute beginnen mögen: Denn will man eine ausbleibende Priorisierung verhindern, ist mit der Entscheidung noch bis zum 1.1.2024 Zeit, da die eigene Spendenbereitschaft erst ab dem 6.7.2024 – sechs Monate später – die Allokation beeinflusst, vgl. § 12 Abs. 3a Nr. 1 TPG. Andererseits verändert sich die Rechtsstellung durch die Priorisierungsregel ganz unabhängig vom Organbedarf. Im Lichte dessen ist neben dem wann der künftigen Betroffenheit von dieser Priorisierung auch bereits vorhersehbar, dass und wie die Entscheidung über die eigene Spendenbereitschaft Auswirkungen auf die Rechtsstellung von T und J haben wird. Außerdem ist auch konkret

absehbar, dass und wie die Regelung eine Beeinflussung der Entscheidungsfindung für oder gegen die Erklärung der eigenen Organspendebereitschaft zukünftig hervorrufen kann. Das genügt nach dem oben dargestellten Maßstab für die gegenwärtige Betroffenheit. In Bezug auf J ergibt sich die Besonderheit, dass diese noch 16 Jahre alt ist. Allerdings fällt sie, wie bereits dargestellt, nicht unter die Ausnahmeregelung des Abs. 3a Nr. 2 TPG, sodass J gleichermaßen heute mit den Überlegungen beginnen muss. Damit hat ihr Alter keine Auswirkungen auf die Gegenwärtigkeit. Folglich sind T und J gegenwärtig betroffen.

Hinweis: In den vorstehenden Kriterien der qualifizierten Betroffenheit schlichen sich bei vielen Studierenden Fehler ein, da entweder verkannt wurde, dass J am 1.7.2024 17 Jahre alt sein wird, und/ oder die Bedeutung der Formulierung „das 17. Lebensjahr nicht vollendet“ verkannt wurde. Auch die Anforderungen an die Gegenwärtigkeit wurden teils verengt dargestellt. Die Ausführungen rund um das Alter konnten kürzer ausfallen, ganz unabhängig davon, ob die zukünftige Betroffenheit auch in Art und Ausmaß feststeht.

c) Unmittelbarkeit

Die Beschwerdeführerinnen müssten auch unmittelbar betroffen sein. Die Unmittelbarkeit ist zu verneinen, wenn zur Durchführung des Gesetzes ein weiterer Vollzugsakt notwendig ist. § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3 TPG bedarf zu seiner Wirkung in Form der Priorisierung und Beeinflussung der Entscheidung keines Vollzugsaktes. Zwar kommt die Priorisierung erst durch die Warteliste zu tragen, Art und Umfang werden jedoch durch das Gesetz unmittelbar bestimmt. T und J sind folglich unmittelbar betroffen. Mithin sind J und T qualifiziert betroffen und somit insgesamt beschwerdebefugt.

II. Zwischenergebnis

Die Verfassungsbeschwerden von T und J sind damit zulässig.

Aufbauhinweis: Eine getrennte Prüfung der Verfassungsbeschwerden ist selbstverständlich möglich.

B. Begründetheit

Weiterhin müssten die Verfassungsbeschwerden auch begründet sein. Dies ist der Fall, wenn eine oder beide der Beschwerdeführerinnen in einem ihrer Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte verletzt sind, vgl. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG.

I. Religionsfreiheit, Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG der T

Zunächst könnte T durch § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG in ihrem Grundrecht auf Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG verletzt sein.

1. Schutzbereich

Dazu müsste zunächst der Schutzbereich des Grundrechts in persönlicher und sachlicher Hinsicht eröffnet sein.

a) Persönlicher Schutzbereich

Einerseits müsste der persönliche Schutzbereich eröffnet sein. In persönlicher Hinsicht schützt Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG jedermann, also jedenfalls jede natürliche Person und damit auch T. Damit ist der persönliche Schutzbereich eröffnet.

b) Sachlicher Schutzbereich

Ebenso müsste § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG ein Verhalten betreffen, das vom sachlichen Schutzbereich der Glaubens- und Religionsfreiheit umfasst ist. Im Glauben äußert sich die religiöse Sinndeutung von Welt und Mensch. Geschützt wird zum einen das Recht, einen Glauben innezuhaben und diesen der Beeinflussung des Staates zu entziehen, was dem forum internum zuzuordnen ist, und zum anderen das forum externum und damit das Recht, den Glauben kundzutun und das gesamte Verhalten an den Lehren dieses Glaubens auszurichten und demgemäß zu handeln. T hat bestimmte Vorstellungen darüber, welche Folgen eine Organspende auf ihr Leben nach dem Tod hat, und sieht sich daher durch das Gesetz in ihrer individuellen Entscheidungsfindung eingeschränkt. Fraglich ist dabei, ob diese zugrundeliegende Glaubensinterpretation der T ausreicht oder der Glaube an eine konkrete Religionsgemeinschaft angebunden sein muss. Die Definitionshoheit über Glauben und Religion zu individualisieren, birgt das Risiko, dass jedwedes Verhalten unter Verweis auf eine (vermeintliche) religiöse Überzeugung unter einen besonderen Schutz gestellt werden könnte. So könnte jedes staatliche Gesetz einen Eingriff in die Religionsfreiheit begründen. Deshalb wird teilweise erwogen, die Interpretation institutionell an Religionsgemeinschaften anzuknüpfen. Dem ist jedoch zu schon in systematischer Hinsicht zu entgegnen, dass es sich bei Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG um ein Individualgrundrecht handelt. Die Anknüpfung an Religionsgemeinschaften und eine

„Mehrheitsüberzeugung“ würde den Schutzbereich erheblich verengen und den Freiheitsschutz des Einzelnen in Abhängigkeit zu anderen stellen. Richtig ist aber auch, dass nach dem oben Gesagten durchaus ein Missbrauchsrisiko besteht. Dem zu begegnen, ist jedoch gleichermaßen innerhalb einer subjektiven Schutzbereichsbestimmung möglich. So ist vor allem eine hinreichend substantiierende Darlegung zu verlangen, dass das Verhalten tatsächlich nach geistigem Gehalt und äußerer Erscheinung in plausibler Weise einer religiösen Motivation folgt (Plausibilitätskontrolle). Die Glaubensvorstellung muss folglich nicht von der Allgemeinheit der Gläubigen geteilt oder religionswissenschaftlich beweisbar sein. Sie muss insbesondere nicht an eine bestimmte Religionsgemeinschaft gekoppelt werden. T legt vorliegend dar, dass sie durch das Gesetz einem Entscheidungsdruck ausgesetzt ist, bei dem eine Entscheidung zur Organspende mit ihren bindenden Glaubensvorstellungen kollidiert. Dabei beruft sie sich auf persönliche Vorstellungen, welche an die christlichen Kirchen angebunden sind, jedoch nicht vollständig mit ihnen übereinstimmen. Sie lebt streng religiös und glaubt an ein Leben nach dem Tod, welches sie jedoch nur als „ganzer Mensch“ mit ihren Organen führen könne. Auch wenn die Vorstellung einer Auferstehung rational unplausibel erscheinen mag, so ist sie doch verschiedensten religiösen Strömungen bekannt. T stellt hierzu einen eigens interpretierten, aber im Lichte dessen nicht unschlüssigen Zusammenhang her. Die Darstellung ist damit plausibel. So verstanden ist eine Organspende mit der Auferstehung und damit ihrem religiösen Konzept unvereinbar. Die freie Entscheidung über die Organspende ist also Teil des forum externum des Glaubens der T. Der Schutzbereich ist somit auch in sachlicher Hinsicht und damit insgesamt eröffnet.

2. Eingriff

§ 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG müsste in den Schutzbereich der Religionsfreiheit eingreifen.

a) Klassischer Eingriffsbegriff

Nach dem klassischen Eingriffsbegriff wird ein Eingriff als „ein rechtsförmiger Vorgang verstanden, der unmittelbar und gezielt (final) durch ein vom Staat verfügtes, erforderlichenfalls zwangsweise durchzusetzendes Ge- oder Verbot, also imperativ, zu einer Verkürzung grundrechtlicher Freiheiten führt“.

aa) Rechtsförmigkeit

§ 12 TPG als formelles Gesetz ist ein Hoheitsakt (der Legislative) und damit rechtsförmig.

bb) Finalität

Weiter müsste dieser Akt final sein, also eine Verkürzung der Freiheit bezwecken. Der Gesetzgeber müsste beabsichtigt haben, einen Entscheidungsdruck bei den Adressaten auszulösen. Ist der Zweck jedoch allein die Priorisierung, so wäre ein Eingriff in Gleichheitsrechte denkbar, einem Eingriff in die Religionsfreiheit genügt dies nicht. Ziel der Gesetzesänderung ist eine Erhöhung der Spenderzahlen. Allein durch eine Priorisierung von spendenwilligen Personen erfolgt jedoch keine automatische Steigerung der Spenderzahlen. Vielmehr erfolgt die Priorisierung nicht nur „priorisierungshalber“, sondern gerade zur Erhöhung der Spenden durch den Druck, der mit der Priorisierung einhergeht. Die Setzung von Anreizen für eine Entscheidung zugunsten der Organspende steht damit im Vordergrund. Dies wirkt auch gegenüber Personen, die dies aus religiösen Gründen ganz oder teilweise ablehnen. Somit wird mit der Norm auch bezweckt, dass die Entscheidung von Personen beeinflusst wird, die aufgrund ihres Glaubens aus Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG nicht spenden wollen oder können. Somit ist der Hoheitsakt auch final.

Hinweis: Eine andere Auffassung ist hier sehr gut vertretbar. Dann sollte schon insoweit auf die Kategorie des mittelbaren, influenzierenden Eingriffs eingegangen werden. Auch von vornherein hierauf abzustellen, wurde nicht negativ bewertet.

cc) Imperativität

Ebenso müsste das staatliche Handeln – hier die Beeinflussung – imperativ wirken, also mit Zwang durchsetzbar sein. Das Gesetz knüpft an eine Entscheidung für oder gegen eine Organspende Priorisierungsfolgen im Krankheitsfalle. Hingegen kann der Einzelne nicht gezwungen werden, sich überhaupt zu entscheiden. Eine Durchsetzung mit Zwangsmitteln ist folglich nicht möglich. Der Hoheitsakt wirkt somit nicht imperativ, womit kein klassischer Eingriff ersichtlich ist.

b) Mittelbarer Eingriff

Die Grundrechte sollen zusätzlich auch vor faktischen oder mittelbaren Beeinträchtigungen durch den Hoheitsträger schützen. Dazu gehören auch sog. influenzierende Eingriffe, bei denen eine Grundrechtsausübung mit einem spürbaren Nachteil verbunden und so Einfluss auf die Willensbildung der Grundrechtsträger genommen wird. Insofern kann auf das Erfordernis der Imperativität verzichtet werden, sofern durch staatliches Handeln eine Verhaltenssteuerung intendiert ist und menschliches Handeln durch das Setzen von Anreizstrukturen in eine bestimmte Richtung gelenkt wird (sog. Nudging). Wie bereits herausgestellt,

beeinflusst die Änderung des TPG die Entscheidungsfindung der Grundrechtsträger. Durch das Gesetz kann T sich nicht frei und entsprechend ihrer religiösen Überzeugung für oder gegen eine Organspende entscheiden. Somit wird durch das Gesetz ein grundrechtlich geschütztes Verhalten erschwert und ein mittelbarer Eingriff liegt vor. § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG greift folglich in die Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG ein.

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

Der Eingriff in den Schutzbereich der Religionsfreiheit könnte jedoch verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein.

a) Schranke des Art. 4 Abs. 1 Var. 1 GG

Das setzt zunächst die Einschränkbarkeit des Grundrechts aus Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG voraus. Art. 4 Abs. 1 und 2 GG nennen keine Schranken der Religionsfreiheit. Trotz fehlender gesetzlicher Normierung kann auch dieses Grundrecht nicht schrankenlos gelten. Stattdessen sind mit dem BVerfG verfassungsimmanente Schranken heranzuziehen.

Hinweis: Hier wird im Sinne der Schwerpunktsetzung auf die Diskussion der Frage verzichtet, ob für Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG die Schranken des Art. 136 Abs. 1, 137 Abs. 3 S. 1 WRV herangezogen werden können. Um dem zu genügen, müsste § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG als einfachgesetzliche Regelung Rechtsgütern von Verfassungsrang dienen und diese konkretisieren. Die Änderungen im TPG zielen auf eine Steigerung der Organspenderzahlen und damit einhergehend einer Senkung der hohen Todeszahlen auf den Wartelisten ab. Zudem führt eine Erhöhung der Spenderanzahl zu einem geringeren Anteil von High-Urgency-Transplantationen, die regelmäßig geringere Erfolgsaussichten aufweisen. Mit der Regelung verfolgt der Gesetzgeber also den Schutz von Leben und Gesundheit der Wartelistenpatienten und kommt seiner Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG in eigenem Ermessen nach. Folglich dient die Norm Rechtsgütern von Verfassungsrang und stellt somit eine taugliche Schranke des Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG dar.

b) Schranken-Schranken, insb. Verhältnismäßigkeit

Der Grundrechtseingriff müsste insbesondere verhältnismäßig sein, wozu die kollidierenden Rechtsgüter innerhalb der Abwägung in einen Ausgleich zu bringen sind. Dabei ist aufgrund der verfassungsimmanenten Schranke des Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG das Prinzip der praktischen Konkordanz zu beachten. Das bedeutet, dass die kollidierenden Rechtsgüter in einen optimalen Ausgleich zu bringen sind und ein besonders strenger Maßstab für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit anzusetzen ist.

aa) Legitimer Zweck

Zuerst müsste ein legitimer Zweck, also ein Allgemeinwohlbelang, vorliegen. Bei einem schrankenlosen Grundrecht bedarf es dazu eines Zwecks von Verfassungsrang. Das ist nach dem Gesagten hier der Schutz von Leib und Leben i.S.d. Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG. Ein legitimer Zweck besteht.

bb) Geeignetheit

Das Gesetz müsste auch geeignet sein. Das ist der Fall, wenn es nicht schlechthin untauglich ist, den legitimen Zweck zumindest zu fördern. § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG bezweckt nach obigen Ausführungen den Schutz von Leben und Gesundheit der Wartelistenpatienten. Der Geeignetheit entgegenstehen könnte derweil die Möglichkeit eines späteren Opt-outs. Denn Personen können zunächst ihren Spenderwillen erklären, um die Vorteile der Priorisierung zu nutzen und die Einwilligung im hohen Alter oder in Ansehung einer lebensgefährdenden Erkrankung wieder zurückziehen. Daraus ergibt sich eine nicht unerhebliche Umgehungsgefahr. Mit Blick auf die breite, aber nicht schriftlich niedergelegte Zustimmung zur Organspende und der meist fehlenden Voraussehbarkeit des Zeitpunkts des eigenen Todes ist eine Umgehung durch die Möglichkeit eines Opt-Outs in solch einem Umfang, dass keine relevante Steigerung der Spenderzahl mehr erreicht werden kann, fernliegend. Eine Förderung des Zwecks ist damit erwartbar. Daher ist die Regelung geeignet.

cc) Erforderlichkeit

Ebenso müsste die Regelung erforderlich sein. Dazu dürfte zur Förderung des legitimen Zwecks kein milderes Mittel gleicher Eignung ersichtlich sein. Eine Alternative stellen Appelle an die Bevölkerung dar, sich für eine Organspende zu entscheiden. Mit der Einführung der sog. Entscheidungslösung im Jahr 2021 erfolgte eine verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien, die Schaffung ärztlicher Beratungsgespräche sowie eine Integration von Grundwissen zur Organspende in Erste-Hilfe-Kursen. All diese Maßnahmen gehen ohne ersichtliche Grundrechtseingriffe einher – sind damit mildere Mittel. Die Anzahl der Organspender konnte aber auch durch diese nicht erhöht werden. Sie sind damit nicht gleichermaßen geeignet.

Weiter könnte man an die Einführung einer Widerspruchslösung denken, die jedoch aufgrund des entstehenden, mittelbaren Zwangs, sich mit der Organspende auseinanderzusetzen und eine Entscheidung zu treffen, nicht milder ist. Bei alternativen Maßnahmen, wie beispielsweise der Adressierung von Mängeln in der Spendererkennung oder der Zulassung von Spenden nach Feststellung des irreversiblen Herztods, ist die Eignung nur schwer vorhersehbar, zumal insoweit eine Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers besteht. Die Regelung ist also erforderlich.

Hinweis: Möglich ist hier durchaus, weitergehend auf die erheblichen Defizite in der Spendererkennung und das damit einhergehende Potential, aber auch auf andere Regelungsoptionen einzugehen. Die Einordnung der dazu vorhandenen Literatur und Studienlage ist jedoch äußert komplex und für eine Anfängerhausarbeit nicht zu erwarten.

dd) Angemessenheit

Die Einschränkung des Grundrechts müsste auch angemessen sein. Die Gesamtabwägung von der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der rechtfertigenden Gründe müsste zugunsten der Rechtfertigung ausgehen. Dabei ist eine praktische Konkordanz herzustellen (siehe oben).

(1) Abstrakte Gewichtung der abzuwägenden Verfassungsgüter

In einer abstrakten Betrachtung stehen sich vorliegend die Schutzpflicht des Staates für Gesundheit und insbesondere das Leben der Wartelistenpatienten (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) und die Freiheit religiöser Überzeugungen potentieller Spender gegenüber. Die Schrankenlosigkeit der Religionsfreiheit unterstreicht dabei ihre besondere verfassungsrechtliche Relevanz. Die Gewährleistung des Lebens der Grundrechtsträger, die der Staat gem. Art. 2 Abs. 2 GG verfolgt, ist zwar „allein“ eine Schutzpflicht des Staates, welche vorliegend einem Individualrechtsgut gegenübersteht, jedoch auch Voraussetzung der individuellen Grundrechtsausübung.

(2) Konkrete Gewichtung

Es gilt nun, das Verhältnis zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Grad der Zweckerreichung konkret abzuwägen. Die Organe stehen in der Verfügungsgewalt der jeweiligen Personen. Die Entscheidung, wie mit diesen nach ihrem Tod verfahren werden soll, wird jedoch durch § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG beeinflusst, wodurch in das Grundrecht auf Religionsfreiheit einzelner Personen eingegriffen wird. Demgegenüber steht jedoch die Schutzpflicht des Staates gegenüber aktuellen und zukünftigen Wartelistenpatienten. Der Staat kann seiner Schutzpflicht durch die Erhöhung von Spenderzahlen besser Rechnung tragen, sodass jeder Grundrechtsträger von der Gesetzesänderung profitieren kann. Die Religionsfreiheit ist derweil für viele Grundrechtsträger von zentraler Bedeutung, weshalb eine Ausnahmeregelung (parallel zu den geregelten Ausnahmen) für Menschen, deren Glauben eine Organspende verbietet, notwendig sein könnte. Dies würde allerdings auf eine Bevorzugung aufgrund eines bestimmten Glaubens hinauslaufen. Außerdem könnte dies mit vermehrten Schutzbehauptungen einhergehen: Grundrechtsträger könnten sich wahrheitswidrig auf die ergänzende Ausnahmeregelung berufen. Die Gesetzesänderung birgt jedoch auch jetzt schon, durch die Möglichkeit des Opt-Outs, eine Missbrauchsgefahr. Wenn dadurch die Zahl der Organspenden letzten Endes nur wenig gesteigert werden kann, kann der Eingriff nicht gerechtfertigt sein. Das Risiko eines solches Missbrauchs ist aufgrund der Unvorhersehbarkeit des eigenen Todes jedoch als gering einzuschätzen. Das Gesetz drängt in doppelter Hinsicht zu einer Entscheidung für eine Organspende, indem es an die Entscheidung zur Organspende gleich mehrere positive Folgen knüpft. Somit ist die Beeinflussung der Entscheidung von gesteigerter Intensität. Dennoch ist zu bedenken, dass laut Sachverhalt die Mehrheit der Bevölkerung (90 %) einer Organentgegennahme zustimmt. Während 84 % eine Organspende befürworten, haben allerdings nur 40 % der Bevölkerung ihre Entscheidung auch dokumentiert. Daher ist zu überlegen, ob der Staat eine solche „Trittbrettfahrerei“ limitieren kann. Denn einerseits verstärken Personen, die sich gegen eine Organspende entscheiden, die Organknappheit. Andererseits wollen eine Vielzahl dieser Personen im Bedarfsfall ein Organ zugeteilt bekommen – erwarten also Solidarität anderer Mitbürger. Im Rahmen einer gerechten Verteilung von medizinischen Ressourcen scheint es daher auch legitim, dass der Gesetzgeber einem solchen Verhalten entgegenwirkt. Zumal die Änderung in § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG dabei noch eine weniger einschränkende Lösung darstellt: Wer selbst kein Organspender sein möchte, der wird nicht von der Versorgung ausgeschlossen und in Situationen extremer Dringlichkeit (sog. HU-Status) wie bisher priorisiert. Indem der Gesetzgeber damit gleichermaßen auf den Schutz Spendenunwilliger abzielt und Priorisierungsanreize auch in ihrem Interesse setzt, kann die Ausübung des Drucks zur positiven Entscheidung einen Ausgleich der Grundrechtspositionen schaffen. So überwiegt die entgegenstehende Schutzpflicht des Staates für Gesundheit und insbesondere Leben der Wartelistenpatienten (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG), weshalb das Gesetz angemessen und somit insgesamt verhältnismäßig ist. § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG stellt somit eine verfassungsrechtlich gerechtfertigte, taugliche Schranke

der Religionsfreiheit dar. Der Eingriff in das Grundrecht der T aus Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG ist mithin verfassungsrechtlich gerechtfertigt.

Hinweis: Eine andere Ansicht ist hier mit entsprechender Begründung (sehr) gut vertretbar.

II. Recht der J und T auf freie Entscheidung über den Umgang mit den Organen nach dem Tod

Weiter könnte das TPG T und J in ihrer Entscheidung über den Umgang mit den Organen nach dem Tod ungerechtfertigt einschränken.

1. Herleitung

Fraglich ist zunächst, durch welches Grundrecht die Entscheidung über die Organe nach dem Tod geschützt wird. Die Entscheidung über die Frage, ob nach dem Tod Organe zur Verfügung gestellt werden, betrifft nicht direkt die körperliche Unversehrtheit, sondern vielmehr die lebzeitige Entscheidung, wie mit dem hirntoten Körper zu verfahren ist. Folglich fällt auch die Entscheidung über eine Organspende nach dem Tod überzeugenderweise in den Schutzbereich des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts (APR) aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG.

Hinweis: Die vorstehende Zuordnung wird in der Literatur durchaus verschiedentlich vorgenommen, wobei die Frage teils offengelassen wird. Aufgrund der Komplexität der Frage wurde eine Streitdarstellung hier nicht zwingend verlangt, aber positiv honoriert. Alle Ansicht sind gleichermaßen vertretbar. Einer anderen als der vorstehenden Ansicht nach fällt die Entscheidung ausschließlich unter Art. 2 Abs. 2 GG, denn dieser umfasse auch das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Gleichermaßen könnte man beide Ansätze für anwendbar halten und das Selbstbestimmungsrecht hinsichtlich einer Organspende sowohl aus Art. 2 Abs. 2 GG als auch aus dem APR ableiten. Für die zweite Ansicht spräche, dass das APR Lücken zum Schutz würderelevanter Verhalten schließen soll. Dem bedürfte es nicht, wenn Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG die Entscheidung über eine Organspende erfasse. Allerdings handelt es sich, wie oben dargestellt, bei der Entscheidung, ob nach dem Tod eine Organspende stattfinden soll, nicht direkt um eine die körperliche Unversehrtheit betreffende Entscheidung, sondern vielmehr um die Frage, wie mit dem hirntoten Körper zu verfahren ist. Zudem wird in der Rechtsprechung schon bei der Selbsttötung unter Verweis auf den Schwerpunkt, der in solchen Fällen auf der Entscheidungsfindung liegt und nicht auf den Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht abgestellt. Dann spricht vieles dafür, erst recht die Entscheidung über die Organspende unter das APR zu fassen. Offenlassen sollte man die Frage, entgegen teilweise vertretener Auffassung, mit Blick auf die unterschiedlichen Schranken der Grundrechte jedoch nicht. Die vorstehenden Überlegungen können auch erst im Rahmen des Schutzbereichs angesprochen werden.

2. Spezialität

Da bezüglich der von T geltend gemachten Beeinflussung bereits der sachliche Schutzbereich der Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG eröffnet ist, stellt sich die Frage der Anwendbarkeit des 22.9.2019, Aufl. 2021, Art. 2 Rn. 207. APR. Einerseits könnte das APR im Wege der Spezialität hinter Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG zurücktreten. Speziellere Freiheitsrechte wie dieses gewähren jedoch nur einen Teilbereich des Schutzes des APR. Während also der religiöse Aspekt unter Art. 4 Abs. 1. Var. 1 GG gedeckt wird, ist die darüberhinausgehende Selbstbestimmung der T nicht durch die Religionsfreiheit geschützt und das APR anwendbar.

3. Schutzbereich

Der Schutzbereich des APR müsste in persönlicher und sachlicher Hinsicht eröffnet sein. Persönlich steht jedermann unter dem Schutz des APR also auch J und T. Ebenso müsste das Verhalten von J und T vom sachlichen Schutzbereich umfasst werden. Das APR kennzeichnet sich durch Flexibilität und umfasst die Sicherung der personalen Selbstentfaltung: Dazu zählen die Selbstdarstellung, Grundbedingungen freier Entfaltung sowie informationelle Selbstbestimmung. Ebenso ist das Verfügungs- bzw. Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper umfasst, sowohl positiv als auch das negative Selbstbestimmungsrecht. Das in Rede stehende Verhalten ist hier die autonome, lebzeitige Entscheidung über die postmortale Organspende, welche unter den sachlichen Schutzbereich des APR fällt. Der Schutzbereich ist folglich eröffnet.

4. Eingriff

§ 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG müsste in das APR eingreifen. Grundrechte dienen auch dem Schutz vor faktischen oder mittelbaren Beeinträchtigungen (vgl. oben). Das Gesetz beeinflusst die freie Willensbildung und damit auch die Möglichkeit, eine autonome Entscheidung ohne staatliche Einflussnahme bezüglich einer Organspende zu treffen. Durch die Norm werden die Grundrechtsträger gezwungen, sich mit der Frage, wie mit ihrem hirntoten Körper nach dem Tod zu verfahren ist, auseinanderzusetzen. Aufgrund des

Entscheidungsdrucks wird das Recht zur selbstbestimmten Entscheidung verkürzt. Ein mittelbarer Eingriff liegt folglich vor.

5. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung, insbesondere Verhältnismäßigkeit

Dieser Eingriff müsste verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein.

a) Schranke des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts

Für die Rechtfertigung von Eingriffen in das APR gelten die Schranken des Art. 2 Abs. 1 GG. Somit dienen als Schranken die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung, sowie die Sittengesetze. Dabei meint die verfassungsmäßige Ordnung die Gesamtheit aller verfassungsgemäßen Rechtsnormen. § 12 TPG kann also eine taugliche Schranke darstellen, sofern er mit der Verfassung in Einklang steht.

b) Schranken-Schranken, insbesondere Verhältnismäßigkeit

Das ist der Fall, soweit die Norm den Schranken-Schranken, insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerecht wird.

aa) Maßstab

Die Selbstbestimmung, welche im Rahmen des APR eine zentrale Rolle spielt, kann auf unterschiedlichen Ebenen betroffen sein. Eine Einordnung erfolgt im Wege einer Einzelfallbetrachtung unter Würdigung der Gesamtumstände und unter Heranziehung der sog. Sphärentheorie. Unterschieden wird zwischen der unantastbaren Intimsphäre, der Privatsphäre, welche aufgrund ihres Sozialbezugs grundsätzlich rechtlichen Regelungen zugänglich ist, und der Sozialsphäre. Je näher der Eingriff an den Kern des Persönlichkeitsrechts heranreicht, desto strengere Anforderungen sind an die Rechtfertigung zu stellen. Bei der Entscheidung über das Verfahren mit dem Körper nach dem Tod, handelt es sich um eine innere Entscheidung, welche neben den Grundrechtsträgern auch potentielle Organempfänger betrifft und sich Institutionen des Gesundheitswesens offenbart. Die Entscheidung ist damit der Allgemeinheit entzogen, gleichwohl aber nicht jedermann. Folglich fällt die Entscheidungsfindung in den Bereich der Privatsphäre. Eingriffe hierin sind nur zulässig, sofern ein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit besteht und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz strikt eingehalten ist.

Aufbauhinweis: Die vorstehenden Erwägungen können gleichermaßen innerhalb der Angemessenheit der Regelung angeführt werden.

bb) Legitimer Zweck

Der Schutz von Leib und Leben ist ein Schutzgut von Verfassungsrang (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) und liegt als Grundbedürfnis des Menschen auf Leben und Gesundheit auch im Interesse der Allgemeinheit. Folglich sind die strengen Anforderungen an den legitimen Zweck gewahrt.

cc) Geeignetheit und Erforderlichkeit der Regelung

Das Gesetz ist nach dem oben Gesagten auch insoweit geeignet und erforderlich, diesen legitimen Zweck zu fördern.

dd) Angemessenheit der Regelung

Gleichermaßen müsste die Regelung auch angemessen sein. Bei der Abwägung der Angemessenheit findet eine Beurteilung der Gesamtumstände statt. Dabei sind aufgrund der Würderelevanz und des damit bestehenden Einflusses von Art. 1 Abs. 1 GG auf das APR strenge Anforderungen an die Angemessenheit zu stellen. Dies folgt auch aus der Zuordnung zur Privatsphäre (siehe oben). Das APR der Spender steht hier der Schutzpflicht des Staates hinsichtlich der Gesundheit der Wartelistenpatienten gegenüber. Insofern kann auf die Abwägungen zur Angemessenheit, insbesondere zur Umsetzung des Gesundheitsschutzes durch § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG und der Bedeutsamkeit des Gesundheitsschutzes, nach oben verwiesen werden. Zu berücksichtigen ist ferner die Intensität des Eingriffs in das APR durch die Gesetzesänderung. Das Gesetz knüpft an die Entscheidung zugunsten einer Organspende gleich zwei positive Folgen: Zum einen die Faktorpriorisierung und zum anderen die Bevorzugung in Pattsituationen. Eine solche Pattsituation liegt vor, wenn sich zwei Personen gegenüberstehen, die beide ein Spenderorgan bedürfen und denen nach medizinischen Maßgaben damit dieselbe Priorität zur Behandlung zukommt. Dadurch entsteht ein erhöhtes Maß an Entscheidungsdruck. Dieser Entscheidungsdruck wirkt auf jeden Adressaten des Gesetzes, sodass die autonome Entscheidung ohne Einflussnahme des Staates für jedermann erschwert wird. Zudem handelt es sich bei der Entscheidung, wie mit dem eigenen Körper nach dem Tod zu verfahren ist, um eine sensible und persönliche Entscheidung, welche der Persönlichkeitssphäre zuzuordnen ist. Deshalb sollte die Entscheidung im Ermessen des Einzelnen stehen und nicht durch Gesetz oder die Allgemeinheit vorgegeben werden. Dem ist entgegenzuhalten, dass das Gesetz durch die Ausnahme in § 12 Abs. 3a TPG

einen Ausnahmetatbestand für Minderjährige schafft. Es wird gewährleistet, dass der Minderjährige erst eine Entscheidung treffen muss, wenn nahe liegt, dass dieser auch geistig dazu in der Lage ist. Auch bei der Grundrechtsmündigkeit kommt es nicht auf die gesetzliche Volljährigkeit an, sondern vielmehr auf die geistige Reife und Einsichtsfähigkeit. Somit wird das Ausmaß der Regelung insgesamt beschränkt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Patienten in einer High-Urgency-Situation weiterhin gem. § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2, 5 TPG bevorzugt behandelt werden. Dieser Umstand spricht für eine geringere Beeinflussung der Entscheidungsfindung, da der Patient bei besonders hoher Dringlichkeit auch ohne die Entscheidung für eine Organspende ein Spenderorgan zugeteilt bekommt. Aufgrund der daraus resultierenden, vergleichsweise geringen Eingriffsintensität überwiegt das Interesse der Allgemeinheit und das des Staates, seiner Schutzpflicht hinsichtlich der Gesundheit der Wartelistenpatienten Genüge zu tun. Folglich ist der Eingriff angemessen und verhältnismäßig. Demnach ist der Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt und § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG verletzt T und J nicht in ihrem APR aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG.

Ggf.: Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 2 GG

Hinweis: Wer sich zuvor gegen die Anwendbarkeit des APR oder für eine Herleitung des Rechts auf Selbstbestimmung über die Verwendung der Organe sowohl aus dem APR als auch Art. 2 Abs. 2 GG entschieden hat, sollte eben dieses Grundrecht nun ansprechen.

III. Gewissensfreiheit, Art. 4 Abs. 1 Var. 2 GG von T und J

Allerdings könnten T und J in ihrem Grundrecht auf Gewissensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 Var. 2 GG verletzt sein.

1. Schutzbereich

Der Schutzbereich müsste in persönlicher und sachlicher Hinsicht eröffnet sein. In persönlicher Hinsicht schützt Art. 4 Abs. 1 GG jedermann. Zumindest also jede natürliche Person und somit auch T und J. Der Schutzbereich ist in persönlicher Hinsicht eröffnet. In sachlicher Hinsicht schützt die Gewissensfreiheit die Handlung, sich nach eigenen sittlichen Maßstäben frei zu entscheiden. Eine solche Gewissensentscheidung ist „jede ernste sittliche, d.h. an den Kategorien von ‚Gut' und ‚Böse' orientierte Entscheidung […], die der Einzelne in einer bestimmten Lage als für sich bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, sodass er gegen sie nicht ohne ernste Gewissensnot handeln könnte". Im Hinblick auf T ist zu beachten, dass diese ihre Überzeugungen ihrem Glauben entnimmt (siehe oben), wofür Art. 4 Abs. 1 Var. 1 GG spezielleres Grundrecht ist. J hingegen gibt an, dass sie sich in einer Entscheidung mit offenem Ausgang beeinflusst fühlt. Es wird jedoch nicht deutlich, dass sie sich durch § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG nicht mehr nach ihren eigenen Maßstäben entscheiden kann, zumal sie insoweit keine Überzeugung darlegt. Damit beeinflusst die o.g. Vorschrift keine Gewissensüberzeugung, sodass der sachliche Schutzbereich des Art. 4 Abs. 1 Var. 2 GG nicht eröffnet ist.

2. Ergebnis

Folglich sind T und J nicht in ihrem Grundrecht auf Gewissensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 Var. 2 GG verletzt.

IV. Weltanschauungsfreiheit, Art. 4 Abs. 1 Var. 4 GG von T und J

Anzudenken ist zudem eine Verletzung der Freiheit des weltanschaulichen Bekenntnisses nach Art. 4 Abs. 1 Var. 4 GG bezüglich T und J.

1. Schutzbereich

Der Schutzbereich des Grundrechts müsste in persönlicher und sachlicher Hinsicht eröffnet sein. Hinsichtlich des persönlichen Schutzbereichs gilt das Gesagte entsprechend. Durch Art. 4 Abs. 1 Var. 4 GG wird der sachliche Schutzbereich auf das weltanschauliche Bekenntnis erstreckt. Das bedeutet, dass der Begriff des Glaubens neben dem religiösen Glauben auch den weltanschaulichen Glauben umfasst. Verlangt wird ein innerweltlicher, immanenter Bezug, also die Überzeugung von der immanenten Wahrheit des Weltganzen und der prinzipiellen Stellung der Menschen in dieser Welt. Bezüglich T, die ihre Überzeugung auf Argumente stützt, die transzendenten Ursprungs sind, ist die Religionsfreiheit spezieller. J hingegen fühlt sich nur in eine Richtung der Entscheidung gedrängt (siehe oben), somit handelt es sich gerade nicht um eine weltanschauliche Gewissheit, die durch § 12 TPG n.F. beeinflusst werden könnte. Der sachliche Schutzbereich ist folglich weder für T noch für J eröffnet.

2. Ergebnis

T und J sind nicht in ihrem Grundrecht auf Weltanschauungsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 Var. 4 GG verletzt.

V. Allgemeine Handlungsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 GG von T und J

Die Allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) tritt aus Gründen der Subsidiarität bezüglich T hinter Art. 4 Abs. 1 Var. 1 GG; bezüglich J tritt Art. 2 Abs. 1 GG hinter dem APR zurück.

VI. Grundrecht auf Gleichbehandlung, Art. 3 Abs. 1 GG durch Zusatzpunkte für Spendenwillige

Schließlich könnten T und J in ihrem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG verletzt sein. Dazu müsste der allgemeine Gleichheitssatz anwendbar sein und eine Ungleichbehandlung vorliegen, die verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist. In Betracht kommt dies hier mit Blick darauf, dass J und T als – zumindest noch – Spendenunwillige im Falle ihrer Bedürftigkeit bei der Organvergabe durch die gesetzliche Neuregelung nicht priorisiert würden, ihr Teilhabeanspruch insoweit also von jenem zur Spende bereiter Personen abweicht.

Hinweis: Zu Art. 3 Abs. 1 GG finden sich in der (Ausbildungs-)Literatur verschiedene Aufbau- und Prüfungsschemata. Im vorliegenden Fall sind verschiedene Strukturen denkbar, auch weil mit der Ungleichbehandlung verschiedene Zwecke verfolgt werden. Wie sich im Folgenden zeigt, ist es aber überzeugend, nicht pauschal Verhältnismäßigkeitsprüfungen durchzuführen. Vielmehr ist auch insoweit der jeweilige Differenzierungszweck maßgeblich.

1. Kein spezieller Gleichheitssatz

Der allgemeine Gleichheitssatz ist subsidiär zu den spezielleren Gleichheitsgrundrechten. Fraglich ist, ob eine Differenzierung „wegen“ des Glaubens i.S.d. Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG vorliegt. Dafür bedürfte es einer direkten Diskriminierung, welche die benachteiligende Maßnahme unmittelbar auf den Glauben bezieht. Das Gesetz knüpft jedoch nicht offen an den Glauben an, sodass keine solche unmittelbare Differenzierung vorliegt. In Frage kommt allenfalls eine mittelbare Ungleichbehandlung von Personengruppen. Auch wenn die Anerkennung einer solchen mittelbaren Ungleichbehandlung i.R.d. Art. 3 Abs. 3 GG durchaus umstritten ist, kommt es darauf zumindest nicht an, wenn eine solche nicht vorliegt. Es ist nicht typisch, dass allein bestimmte Religionen sich gegen eine Organspende aussprechen und rein tatsächlich so nur oder ganz überwiegend Personen mit einer Religionsangehörigkeit (mittelbar) benachteiligt werden. Vielmehr gibt es auch Menschen, die sich aus anderen Motiven gegen eine Organspende entscheiden. Somit liegt auch eine mittelbarfaktische Diskriminierung wegen des Glaubens schon nicht vor. Somit ist Art. 3 Abs. 3 GG nicht einschlägig, sodass der allgemeine Gleichheitssatz anwendbar ist.

2. Ungleichbehandlung

§ 12 Abs. 3 S. 2 TPG vergibt Zusatzpunkte für spendenwillige Personen für den Fall ihrer Organbedürftigkeit, wobei die Punkte nur vor der Organbedürftigkeit durch die eigene Entscheidung für die Organspende „erworben“ werden können. Nach § 12 Abs. 3 S. 3 TPG erfolgt dann auch Priorisierung zugunsten Spendenwilliger in Pattsituationen. Hingegen werden Spendenunwilligen diese Vorteile bei der Vergabe nicht zuteil. Insoweit liegt eine Ungleichbehandlung von potenziellen Organspendern in Bezug auf ihren Teilhabeanspruch vor.

3. Rechtfertigung der Ungleichbehandlung

Diese Ungleichbehandlung von Spendenwilligen und -unwilligen könnte verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein.

a) Prüfungsmaßstab

Für die Prüfung des allgemeinen Gleichheitssatzes gilt ein gleitender Prüfungsmaßstab. Die Verfassungsrechtsprechung hat das folgendermaßen zusammengefasst: „Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen. Die Abstufung der Anforderungen folgt aus Wortlaut und Sinn des Art. 3 Abs. 1 GG sowie aus seinem Zusammenhang mit anderen Verfassungsnormen. Da der Grundsatz, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, in erster Linie eine ungerechtfertigte Verschiedenbehandlung von Personen verhindern soll, unterliegt der Gesetzgeber bei einer Ungleichbehandlung von Personengruppen regelmäßig einer strengen Bindung. Diese Bindung ist umso enger, je mehr sich die personenbezogenen Merkmale den in Art. 3 Abs. 3 GG genannten annähern und je größer deshalb die Gefahr ist, dass eine an sie anknüpfende Ungleichbehandlung zur Diskriminierung einer Minderheit führt. Die engere Bindung ist jedoch nicht auf personenbezogene Differenzierungen beschränkt. Sie gilt vielmehr auch, wenn eine Ungleichbehandlung von Sachverhalten mittelbar eine Ungleichbehandlung von Personen bewirkt. Bei lediglich verhaltensbezogenen Unterscheidungen hängt das Maß der Bindung davon ab, inwieweit die Betroffenen in der Lage sind, durch ihr Verhalten die Verwirklichung der Merkmale zu beeinflussen, nach denen unterschieden wird. (...) Der

unterschiedlichen Weite des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums entspricht eine abgestufte Kontrolldichte bei der verfassungsgerichtlichen Prüfung. Kommt als Maßstab nur das Willkürverbot in Betracht, so kann ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG nur festgestellt werden, wenn die Unsachlichkeit der Differenzierung evident ist. Dagegen prüft das Bundesverfassungsgericht bei Regelungen, die Personengruppen verschieden behandeln [...], im Einzelnen nach, ob für die vorgesehene Differenzierung Gründe von solcher Art und solchen Gewicht bestehen, dass sie die ungleichen Rechtsfolgen rechtfertigen können."

b) Rechtfertigungsprüfung

Die gesetzliche Differenzierung knüpft vorliegend an die Spendenbereitschaft an, mithin nach dem dargestellten Maßstab an ein verhaltensbezogenes Merkmal. Andererseits berührt die Differenzierung mit der Selbstbestimmung, der körperlichen Unversehrtheit und ggf. dem Leben grundrechtliche Schutzgüter. Insgesamt ist daher nicht von einer reinen Willkürkontrolle auszugehen, sondern zu fragen, ob zwischen den Vergleichspersonen Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die Ungleichbehandlung rechtfertigen können. Durch die Neuregelung(en) werden derweil zwei Ziele verfolgt: Einerseits die Begünstigung spendenbereiter Personen und andererseits die hierdurch bewirkte Anreizsetzung, selbst die Spendenbereitschaft zu erklären.

aa) Begünstigung von Spendenwilligen

Die Spendenbereitschaft bzw. Spendenunwilligkeit stellt einen relevanten Unterschied zwischen den Vergleichspersonen dar, der für die Organverteilung auch nicht sachfremd ist: In einem geschlossenen System der Organallokation ist es nicht fernliegend, dass vorrangig diejenigen mit einem Organ bedacht werden, die auch selbst zu dem Organaufkommen beizutragen bereit sind. Damit liegt der Art nach ein Differenzierungsgrund vor, der die Begünstigung rechtfertigen kann. Indem die Spendenbereitschaft erst dazu führt, dass es ein zu verteilendes Gut gibt, ist sie als Grund der Ungleichbehandlung hier von größtem Gewicht – mit anderen Worten: Sie ist existenzielle Voraussetzung einer Organallokation. Damit besteht hier ein Unterschied, der nach Art und Gewicht die Ungleichbehandlung rechtfertigt.

Hinweis: Teils wird auch in Bezug auf solche „interne" Zwecke, also Zwecke, bei denen die Ungleichbehandlung nicht in Verhältnis mit einer außerhalb der Personen stehenden Zielverfolgung stehen, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt. Das ist jedoch dogmatisch fragwürdig: Wenn etwa nach der Geeignetheit gefragt würde, müsste hier formuliert werden: „Fraglich ist, ob die Begünstigung Spendenwilliger geeignet ist, den legitimen Zweck der Begünstigung Spendenwilliger zumindest zu fördern." Das kann nicht richtig sein. Wenn der Zweck der Differenzierung die Differenzierung selbst ist, und kein externer Zweck (wie im Folgenden die Anreizsetzung), dann sollte insoweit auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung verzichtet werden und allein gefragt werden, ob die Unterschiede der Vergleichsgruppen solcher Art und solchen Gewichts sind, die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. Das ist aber nicht dasselbe wie eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die Erwägungen insbesondere zu der Umgehungsmöglichkeit der Regelung, die im Folgenden unter der Anreizsetzung diskutiert werden, könnten hingegen durchaus auch in die Bewertung des Gewichts der Ungleichbehandlung einfließen.

bb) Anreizsetzung

Auch die zweite Zwecksetzung, die Spendenbereitschaft durch Anreizsetzung zu erhöhen und damit die Versorgung mit Organen zu verbessern, könnte die Ungleichbehandlung rechtfertigen. Sie dient dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) und ist damit legitim. Die Differenzierung bei der Organallokation nach der Spendenbereitschaft ist geeignet, dieses Ziel zu fördern – insbesondere wecken potenzielle Umgehungsmöglichkeiten durch ein späteres Opt-Out nach dem zuvor in der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die Religionsfreiheit Gesagten keine durchgreifenden Bedenken. Auch ist keine andere Differenzierung ersichtlich, die dies in gleicher Weise erreicht, sodass die Ungleichbehandlung auch erforderlich ist. Mit Blick auf die Angemessenheit der Differenzierung ist jedoch fraglich, ob verhaltensbezogene Kriterien wie die Spendenbereitschaft zur Verfolgung des externen Zwecks überhaupt berücksichtigt werden dürfen. Eine Ansicht lehnt eine Anknüpfung an verhaltensbezogene Kriterien mit der Begründung ab, dass ein Teilhabeanspruch voraussetzungslos bestünde und sich die Zuteilungsentscheidung allein nach der Dringlichkeit und Bedürftigkeit richten dürfe. Andererseits wird vertreten, dass eine Anknüpfung an ein verhaltensbezogenes Kriterium, wie die Spendenbereitschaft, zulässig sei: Außermedizinische Kriterien seien nicht per se ausgeschlossen, vielmehr handele es sich bei dem Kriterium der Spendenbereitschaft um ein sachbezogenes Kriterium, welches Berücksichtigung finden darf. Aufgrund der Organknappheit müssten Kriterien zur Entscheidungsfindung herangezogen werden und selbst bei Anknüpfen an Kriterien wie der Spendenbereitschaft bliebe der Zugang und die Motivationsgrundlage für alle Menschen gleich. Für die zweite Ansicht spricht, dass sich aus verfassungsrechtlicher Sicht keine Anhaltspunkte ergeben, bei Knappheit allein nach medizinischen Kriterien zu differenzieren. Insbesondere in Entscheidungssituationen, bei denen die Patienten dieselbe medizinische Lage aufweisen, ist eine medizinische Entscheidung schon

nicht möglich, gleichwohl notwendig. Außerdem folgt schon aus der Gewichtung medizinischer Kriterien immer auch eine Wertentscheidung – eine reinmedizinische Priorisierung ist damit kaum möglich. Andernfalls müsste nach dem Zufallsprinzip oder immerzu allein nach Dringlichkeit entschieden werden. Dass dies verfassungsrechtlich zwingend ist, ist nicht ersichtlich. Folglich ist eine Anknüpfung an verhaltensbezogene Kriterien bei der Entscheidung über die Zuteilung eines Organs zulässig, sofern diese zumindest sachbezogen sind. Dennoch muss das bezweckte Ziel der Differenzierung in einer konkreten Abwägung gegenüber der Grundrechtseinschränkung überwiegen. Für eine Angemessenheit der Differenzierung durch § 12 Abs. 3 S. 2, S. 3, Abs. 3a TPG spricht, dass er Ausnahmen für einwilligungsunfähige Personen sowie Wartezeiten vorsieht. Ebenso wird eine informierte Einwilligung sichergestellt. Eine ähnliche Differenzierung nach dem Vorverhalten kennt das deutsche Recht zudem im Krankenkassensystem: Wer entgegen seiner Pflicht keine Beiträge zahlt, fällt auf eine Minimalversorgung zurück. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass eine Organvergabe eine lebensnotwendige Behandlung darstellt. Solche beinhaltet auch die Minimalversorgung. Zudem können Patienten nur innerhalb des Systems des TPG an ein Spenderorgan gelangen, weshalb dem Staat im Zusammenhang mit der Organtransplantation eine Monopolstellung bezüglich einer knappen Ressource zukommt. Derweil ergibt sich aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ein gleichwertiger Teilhabeanspruch aller Menschen. Konkret bedeutet dies, dass jeder Mensch einen gleichheitskonformen Zugangsanspruch zu Gesundheitsleistungen hat. Daraus folgt, dass die aufgrund der Ungleichbehandlung entstehenden Nachteile von hoher Intensität sind. Bedenken bestehen zunächst bezüglich der Priorisierung nach § 12 Abs. 3 S. 2 TPG: Durch die Priorisierung um den Faktor 1,5 wird der Spendenbereitschaft ein erhebliches Gewicht eingeräumt, das die medizinischen Nöte zu verdrängen droht. Zudem könnte durch die Regelung eine Priorisierung zur Regel werden, wenn die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich für eine Spende entscheidet. Dem ist zu erwidern, dass eine erhebliche Priorisierung einen starken Anreiz zur Spende schafft. Eine hohe Anzahl von Spendenwilligen hilft zum einen mehr Menschen lebensrettende Organe zuzuteilen. Zum anderen profitieren gerade auch die Spendenunwilligen erheblich von einer so entstehenden Erweiterung des Spendenpools. Dass eine Spendeneinwilligung „zur Regel“ wird, wäre somit gerade auch im Interesse der Nicht-Spender und für sie in Teilen vorteilhaft. Problematisch erscheint, dass der Faktor für die Priorisierung ohne wissenschaftliche Grundlage festgelegt wurde. Jedoch sind Priorisierungsentscheidungen immer auch wertend und nicht stets einer Evidenz zugänglich. So muss dem Staat insoweit ein gewisser Gestaltungsspielraum zustehen. Die Priorisierung um den Faktor 1,5 erscheint mit Blick auf eine potenzielle Erhöhung der Spenderzahlen nicht außer Verhältnis. Zwar ist die Faktorisierung um 1,5 von erheblichem Gewicht. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass gemäß der Regelungen nach dem TPG weiterhin in erster Linie, genau genommen zu 2/3, an medizinische Kriterien angeknüpft wird und dass in High-Urgency-Situationen die Entscheidung ohne Ansehung der eigenen Spendenbereitschaft zugunsten des Patienten, der sich in der dringlich(st)en Situation befindet, erfolgt. Bedenken in Bezug auf die Angemessenheit der gesetzgeberischen Gewichtung bestehen auch im Hinblick auf die Priorisierung in Pattsituationen nach § 12 Abs. 3. S. 3 TPG, denn insbesondere in dieser Differenzierung könnte ein Verstoß gegen die Lebenswertindifferenz liegen: Der Lebenswertindifferenzlehre nach ist menschliches Leben keiner Bewertung zugänglich. Demzufolge wäre ein Gesetz, das bestimmte Personen oder Personengruppen von lebenserhaltenden Leistungen ausschließt und dies mit dem geringeren Nutzen des Lebenserhalts begründet, verfassungswidrig. Jedoch wird eine Benachteiligung hier nicht mit dem „weniger-Wert-sein“ der Spendenunwilligen begründet. Es wird nicht zwischen lebenswertem und -unwertem Leben entschieden, sondern an ein sachbezogenes Vorverhalten angeknüpft, um ein Patt aufzulösen. Die Entscheidung muss in diesen – sehr seltenen, wenn nicht hypothetischen – Fällen also zwangsläufig erfolgen. Auch wenn die Differenzierung faktisch bewirkt, dass Spendenunwillige auf Grundlage ihres Verhaltens schlechter gestellt werden, ist zu berücksichtigen, dass das System der Organverteilung auf dem Prinzip der Solidarität beruht. Daher kann die Zuweisung von Organen, auch an Personen, die eine Spende ablehnen, erleichtert werden, wenn Vorschriften gezielt den Gedanken der Solidarität umsetzen und fördern, was zu einer größeren Anzahl verfügbarer Spenderorgane führt. Die Privilegierung der spendenbereiten Personen trägt somit zu einer gerechteren und abgesicherten Teilhabe aller Patienten bei. Folglich überwiegt der Zweck der Differenzierung – die Anreizsetzung – gegenüber der Grundrechtseinschränkung hinsichtlich beider Regelungen. Somit ist die Ungleichbehandlung angemessen und insgesamt verhältnismäßig.

c) Zwischenergebnis

Die Ungleichbehandlung(en) Spendenwilliger bzw. Spendenunwilliger in § 12 TPG n.F. sind verfassungsrechtlich gerechtfertigt.

4. Zwischenergebnis

Mithin verletzten die Regelungen auch Art. 3 Abs. 1 GG nicht.

VII. Ergebnis zur Begründetheit

Die Verfassungsbeschwerden von J und T sind zulässig, aber unbegründet.

C. Endergebnis

Die Verfassungsbeschwerden haben keinen Erfolg.